Estilo UERJ

Simulado 15 Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	13	11, 16, 19, 20, 23, 25, 27, 32, 33, 36, 40, 46, 49
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	7	2, 8, 17, 29, 41, 48, 50
Dado omitido	o achado mais famoso foi retirado	1	22
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	5	6, 12, 28, 34, 35
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	5	10, 13, 26, 39, 45
Qualificador	o comando restringe o que se pede	6	1, 4, 9, 15, 30, 31
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	5	18, 24, 37, 38, 43
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	3	14, 42, 44
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	5	3, 5, 7, 21, 47

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante em 15/10/2026.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **B**	2 **A**	3 **A**	4 **B**	5 **C**	6 **D**	7 **C**	8 **A**	9 **C**	10 **D**
11 **C**	12 **C**	13 **C**	14 **D**	15 **A**	16 **C**	17 **D**	18 **B**	19 **B**	20 **D**
21 **B**	22 **D**	23 **C**	24 **C**	25 **A**	26 **A**	27 **A**	28 **B**	29 **D**	30 **C**
31 **A**	32 **B**	33 **D**	34 **D**	35 **C**	36 **B**	37 **A**	38 **A**	39 **D**	40 **A**
41 **A**	42 **B**	43 **D**	44 **D**	45 **B**	46 **B**	47 **C**	48 **B**	49 **B**	50 **A**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 13, B 13, C 12, D 12.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1

Hematologia · Transfusão maciça empírica: plasma, plaquetas e hemácias na proporção de 1:1:1

Qualificador **Gabarito B**

Na transfusão maciça empírica do paciente com hemorragia grave, antes de haver resultado de coagulograma ou de teste viscoelástico, a proporção de plasma, plaquetas e concentrado de hemácias que resultou em melhor hemostasia e menos mortes por exsanguinação nas primeiras 24 horas é:

O DADO QUE DECIDE

menos mortes por exsanguinação nas primeiras 24 horas

Resolução. A proporção 1:1:2 (uma unidade de plasma e uma de plaquetas para cada duas de hemácias) foi o padrão de muitos protocolos e também é uma relação alta, o que a torna atraente. O estudo PROPPR comparou diretamente 1:1:1 com 1:1:2 no trauma com hemorragia grave: não houve diferença de mortalidade total em 24 horas e 30 dias, mas o grupo 1:1:1 atingiu hemostasia com mais frequência e teve menos mortes por exsanguinação nas primeiras 24 horas, sem aumento de complicações. Por isso os protocolos de transfusão maciça empírica usam proporções próximas de 1:1:1 até que exames de coagulação ou viscoelásticos permitam guiar a reposição por metas. O qualificador do comando (empírica, antes dos exames, exsanguinação) é o que separa as duas respostas.

A) 1:2:4
Errada. Proporção baixa de plasma e plaquetas, que agrava a coagulopatia dilucional.

B) 1:1:1 CORRETA
Correta. No PROPPR, 1:1:1 deu mais hemostasia e menos mortes por exsanguinação em 24 horas.

C) 1:1:2 ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Foi o braço comparador do PROPPR, sem vantagem em hemostasia e com mais mortes por exsanguinação.

D) 2:1:1
Errada. Excesso de plasma sem base em estudo, com mais sobrecarga de volume e citrato.

Para levar. Transfusão maciça empírica: plasma, plaquetas e hemácias perto de 1:1:1 até que exames permitam guiar por metas.

Holcomb JB et al., PROPPR (JAMA 2015); European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma, 6ª edição (2023).

2 Neurologia · Infarto cortical na mulher de 46 anos com forame oval, shunt grande e aneurisma de septo, sem fibrilação atrial nem trombose: fechamento percutâneo com antiagregação

Negativo no meio **Gabarito A**

Mulher de 46 anos, sem hipertensão, diabetes, tabagismo ou dislipidemia, teve afasia e hemiparesia direita súbitas há 3 semanas ao levantar peso na academia, com recuperação quase completa. RM: infarto cortical frontal esquerdo único. Angiotomografia de vasos cervicais e intracranianos sem dissecção, estenose ou placa. Ecocardiograma transesofágico: forame oval patente com passagem de mais de 30 microbolhas após manobra de Valsalva e aneurisma do septo interatrial, sem trombo ou vegetação. Holter de 30 dias sem fibrilação atrial; ultrassonografia venosa dos membros inferiores normal; anticardiolipina, anti-beta2-glicoproteína I e anticoagulante lúpico negativos. Para prevenção secundária, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Holter de 30 dias sem fibrilação atrial; ultrassonografia venosa dos membros inferiores normal

Resolução. Embolia paradoxal faz pensar em trombo venoso e, por extensão, em anticoagular, e é a armadilha. Os negativos do meio do caso tiram a anticoagulação do lugar: não há trombose venosa documentada, não há fibrilação atrial em 30 dias de monitorização e a síndrome antifosfolípide foi afastada. O que sobra é um infarto cortical de aspecto embólico, numa mulher de 46 anos sem fatores de risco, com forame oval de alto risco (shunt grande e aneurisma do septo, RoPE alto, PASCAL provável), com o evento durante Valsalva. Nesse perfil, entre 18 e 60 anos, o fechamento percutâneo seguido de antiagregação reduz recorrência em relação ao tratamento clínico isolado (CLOSE, REDUCE, RESPECT). Antiagregação sem fechamento seria a opção se o forame fosse de baixo risco ou se ela recusasse o procedimento; anticoagulação ficaria para trombose venosa ou outra indicação própria.

A) Fechamento percutâneo com AAS CORRETA
Correta. Infarto embólico sem outra causa, idade abaixo de 60 e forame oval com shunt grande e aneurisma de septo: fechamento e antiagregação.

B) AAS isolado, sem fechamento
Errada. Seria a escolha no forame oval de baixo risco (shunt pequeno, sem aneurisma) ou com outra causa provável; aqui o fechamento reduz recorrência.

C) Anticoagulação oral indefinida ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Anticoagulação seria indicada com trombose venosa, fibrilação atrial ou síndrome antifosfolípide, todas afastadas.

D) Dupla antiagregação por 21 dias
Errada. Dupla antiagregação por 21 dias é para AVC menor ou AIT de alto risco não cardioembólico na fase aguda; não trata a causa e o evento foi há 3 semanas.

Para levar. AVC embólico sem outra causa, entre 18 e 60 anos, com forame oval de alto risco (shunt grande ou aneurisma de septo): fechamento percutâneo e antiagregação; anticoagular só se houver indicação própria.

AHA/ASA 2021 Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and TIA; Kavinsky CJ et al. SCAI Guidelines for the Management of Patent Foramen Ovale 2022; Kent DM et al. Heterogeneity of treatment effects of PFO closure (PASCAL), JAMA 2021.

3 Infectologia · Infecção aguda pelo HIV com carga viral muito alta: TARV no mesmo dia, sem esperar a genotipagem

Cronologia **Gabarito A**

Homem de 29 anos procura atendimento com febre, odinofagia, exantema maculopapular no tronco e linfonodomegalia cervical há 8 dias, 4 semanas após relação anal sem preservativo com parceiro de sorologia desconhecida. Imunoensaio de 4ª geração reagente, com carga viral de 2.300.000 cópias/mL e CD4 de 410 células/mm³. Sem gestação de parceria, sem doença renal, sem hepatite B (HBsAg não reagente). A genotipagem pré-tratamento foi colhida, com resultado previsto em 30 dias. Ele está motivado e quer começar o tratamento. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

com resultado previsto em 30 dias

Resolução. A genotipagem colhida e a lembrança de que ela orienta a troca de esquema na falha fazem parecer prudente esperar o resultado. Na infecção aguda, isso é o erro de cronologia: o período de carga viral altíssima é o de maior transmissibilidade e de formação do reservatório, e a TARV precoce reduz transmissão, preserva a imunidade e encurta a síndrome aguda. O PCDT recomenda tratar toda pessoa com HIV independentemente do CD4 e, na infecção aguda, iniciar logo, com a genotipagem colhida antes mas sem aguardar o resultado. O dolutegravir tem barreira genética alta, e a resistência transmitida a ele é rara, enquanto a resistência transmitida aos inibidores de transcriptase não análogos (que motivava a espera) não afeta este esquema. Se a genotipagem mostrar alguma mutação relevante, o esquema é ajustado depois.

A) Iniciar TARV hoje, com dolutegravir CORRETA
Correta. Infecção aguda é indicação de TARV imediata, com dolutegravir, sem esperar a genotipagem colhida antes.

B) Aguardar o CD4 sair da fase aguda
Errada. O CD4 não condiciona o início da TARV; esperar a fase aguda passar mantém a fase de maior transmissão.

C) Aguardar o resultado da genotipagem ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a genotipagem é colhida antes, mas não se espera o resultado, porque o dolutegravir raramente é afetado pela resistência transmitida.

D) Tratar só se o CD4 cair abaixo de 350
Errada. O critério de CD4 para iniciar TARV foi abandonado há anos; todos são tratados.

Para levar. Na infecção aguda pelo HIV, colher a genotipagem e iniciar tenofovir, lamivudina e dolutegravir no mesmo dia, sem esperar o resultado.

Ministério da Saúde, PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos, módulo 1 (2024); DHHS Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults (2024).

4

Cardiologia · Estenose aórtica: o achado de exame físico que, isoladamente, mais indica gravidade é o pico tardio do sopro, e não a sua intensidade

Qualificador

Gabarito B

Na estenose aórtica valvar do adulto, o achado do exame físico que, isoladamente, mais sugere lesão grave é:

O DADO QUE DECIDE

isoladamente, mais sugere lesão grave

Resolução. A intensidade do sopro é a isca, porque o senso comum associa sopro alto a lesão grave. Mas a intensidade depende do débito: na estenose grave com disfunção ventricular, baixo fluxo ou obesidade, o sopro pode ser discreto, e um sopro alto pode acompanhar estenose moderada com débito alto. O que acompanha a gravidade é o tempo: quanto mais apertada a valva, mais tarde na sístole ocorre o pico do gradiente, e o sopro em diamante passa a ter pico telessistólico. Os outros marcadores de gravidade são o pulso parvus et tardus, a hipofonese ou ausência de A2 e o desdobramento paradoxal de B2. O clique de ejeção indica valva ainda móvel, em geral bicúspide e não muito calcificada, e desaparece quando a calcificação a imobiliza; a irradiação para o ápice é o fenômeno de Gallavardin, sem relação com gravidade.

A) Irradiação do sopro para o ápice

Errada. A irradiação para o ápice (Gallavardin) reflete transmissão dos componentes musicais do sopro e não gradua a lesão.

B) Pico tardio do sopro sistólico CORRETA

Correta. O pico do sopro desloca-se para o fim da sístole à medida que a estenose se agrava, e acompanha a gravidade independentemente do débito.

C) Clique de ejeção aórtico

Errada. O clique de ejeção indica folhetos móveis (valva bicúspide pouco calcificada) e some com a calcificação avançada, típica da estenose grave do idoso.

D) Sopro de intensidade 4/6 com frêmito ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. A intensidade varia com o débito e pode cair justamente na estenose grave com disfunção do VE; frêmito sugere gradiente alto, mas não é o melhor marcador isolado.

Para levar. Na estenose aórtica, gravidade é tempo e não volume: pico telessistólico do sopro, pulso parvus et tardus, A2 hipofonética ou ausente e desdobramento paradoxal de B2.

Braunwald's Heart Disease, 12ª ed. (2022), capítulo de estenose aórtica; Diretriz Brasileira de Valvopatias SBC 2020; ACC/AHA 2020 Guideline for valvular heart disease

---

5

Hepatologia · Aminotransferases acima de 3.000 após choque, com LDH muito alta e queda rápida em 48 horas: hepatite isquêmica

Cronologia

Gabarito C

Homem de 70 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção de 25%, é internado por pneumonia e evolui no 1º dia com choque séptico (PA 70×40 mmHg por cerca de 4 horas, até iniciar noradrenalina). Iniciou amoxicilina-clavulanato e azitromicina na admissão. Exames no 1º dia: AST 150 U/L, ALT 120 U/L. No 2º dia: AST

5.800 U/L, ALT 3.900 U/L, LDH 6.100 U/L, bilirrubina 2,0 mg/dL, INR 2,1, creatinina 2,4 mg/dL. No 4º dia: AST 1.200 U/L, ALT 1.700 U/L, INR 1,5, bilirrubina 2,4 mg/dL. Não usou paracetamol. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

No 4º dia: AST 1.200 U/L, ALT 1.700 U/L

Resolução. A amoxicilina-clavulanato é a droga que mais causa lesão hepática induzida por medicamento, e está no caso desde a admissão. Mas a lesão por ela costuma ser colestática ou mista e aparecer dias a semanas depois, não um pico de milhares de U/L 24 horas após um episódio de choque. A cronologia decide: elevação maciça das aminotransferases logo após hipotensão, em quem já tem baixo débito, com LDH muito alta (relação ALT/LDH abaixo de 1,5), coagulopatia e lesão renal simultâneas, e queda rápida, de mais de 50% em 48 a 72 horas, é a hepatite isquêmica (fígado de choque). A hepatite viral aguda sobe e desce mais devagar e teria LDH proporcionalmente menor. A colangite isquêmica secundária é complicação tardia da UTI, com colestase progressiva, e não pico de aminotransferases.

A) Hepatite viral aguda
Errada. A viral sobe ao longo de dias e cai lentamente, com LDH proporcionalmente baixa; não começaria um dia após o choque.

B) Colangite isquêmica secundária
Errada. É complicação tardia de UTI, colestática (fosfatase e GGT), não pico precoce de aminotransferases.

C) Hepatite isquêmica CORRETA
Correta. Pico de milhares logo após choque, LDH muito alta e queda rápida em 48 a 72 horas.

D) Lesão hepática por amoxicilina-clavulanato ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a droga existe, mas a lesão por ela é tardia e colestática ou mista; o tempo e a curva não combinam.

Para levar. Hepatite isquêmica: aminotransferases em milhares 1 a 3 dias após hipotensão, LDH muito alta e queda de mais de 50% em 48 a 72 horas.

ACG Clinical Guideline: Evaluation of Abnormal Liver Chemistries (2017); Waseem N, Chen PH. Hypoxic hepatitis: a review and clinical update. J Clin Transl Hepatol (2016)

6

Imunologia e alergia · Febre, sintomas gastrointestinais e respiratórios que pioram a cada dose na segunda semana de antirretroviral: hipersensibilidade ao abacavir a deduzir

Droga a deduzir | Gabarito D

Homem de 38 anos com HIV, sem tratamento prévio, CD4 de 450 células/mm³ e sem infecção oportunista, tem doença renal crônica com taxa de filtração de 38 mL/min/1,73 m². Há 9 dias iniciou um comprimido único diário com dolutegravir, lamivudina e um terceiro antirretroviral escolhido para evitar o tenofovir; a genotipagem do HLA não estava disponível. Há 2 dias tem febre de 38,6 °C, náuseas, vômitos, diarreia, mialgia, dor de garganta e tosse seca, que pioram nas horas seguintes a cada comprimido, e exantema maculopapular discreto no tronco. Exame físico: sem lesões mucosas, sem linfonodomegalias. Exames: eosinófilos 200/mm³, transaminases normais, radiografia de tórax normal. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

pioram nas horas seguintes a cada comprimido

Resolução. Febre logo depois de iniciar antirretroviral lembra síndrome de reconstituição imune, mas ela exige uma infecção oportunista a desmascarar e costuma ocorrer em CD4 baixo; aqui o CD4 é 450 e não há infecção. A droga está a deduzir: o comprimido único com dolutegravir, lamivudina e um terceiro fármaco usado para poupar o rim do tenofovir contém abacavir. A hipersensibilidade ao abacavir surge em mediana de 8 a 11 dias (quase sempre nas primeiras 6 semanas), com febre, exantema muitas vezes discreto, sintomas gastrointestinais e respiratórios, e piora a cada dose; associa-se ao HLA-B*57:01, que deve ser pesquisado antes de prescrever. Suspende-se o abacavir e não se reintroduz nunca, porque a reexposição pode ser fatal. DRESS teria latência maior, eosinofilia e hepatite.

A) DRESS pelo dolutegravir
Errada. DRESS surge após 2 a 8 semanas, com eosinofilia, hepatite e linfonodomegalia, ausentes aqui.

B) Síndrome inflamatória de reconstituição imune ARMADILHA
Errada. Exige infecção oportunista desmascarada, em geral com CD4 baixo; não há nenhuma das duas.

C) Gastroenterite viral aguda
Errada. Não explica febre, exantema e sintomas respiratórios que pioram a cada dose.

D) Hipersensibilidade ao abacavir CORRETA
Correta. Início na segunda semana, sintomas multissistêmicos que pioram a cada dose: abacavir, que não pode ser reintroduzido.

Para levar. Abacavir: pesquisar HLA-B*57:01 antes; febre com sintomas gastrointestinais e respiratórios que pioram a cada dose nas primeiras semanas é hipersensibilidade, e o fármaco nunca mais volta.

DHHS Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV (2024); PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos, Ministério da Saúde.

7

Nefrologia · Placas violáceas dolorosas com necrose nas coxas da dialítica em uso de varfarina há dois anos · calcifilaxia, e não necrose pela varfarina

Cronologia **Gabarito C**

Mulher de 62 anos, obesa (IMC 38 kg/m²), diabética, em hemodiálise há seis anos, em uso de varfarina há dois anos por fibrilação atrial (INR entre 2 e 3 nos controles), carbonato de cálcio como quelante e calcitriol. Há três semanas surgiram placas violáceas em padrão rendilhado, muito dolorosas e endurecidas, na face interna das coxas e no abdome inferior; duas delas têm agora escara necrótica central. Pulsos pediosos presentes. Sem febre, sem eosinofilia, sem cateterismo ou outro procedimento vascular recente. Exames: cálcio 10,1 mg/dL, fósforo 7,2 mg/dL, PTH 1.150 pg/mL, albumina 3,2 g/dL; ANCA, FAN e crioglobulinas negativos. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

em uso de varfarina há dois anos

Resolução. Necrose de pele em área de gordura (coxas, abdome, mamas) em quem usa varfarina lembra a necrose cutânea da varfarina, e a droga é real. Mas essa necrose aparece nos primeiros dias depois de iniciar o antagonista da vitamina K (por queda rápida da proteína C), e não depois de dois anos de uso estável. Em

dialítica obesa e diabética, com fósforo alto, PTH muito elevado, quelante com cálcio e calcitriol, placas rendilhadas extremamente dolorosas que necrosam em áreas de tecido adiposo são calcifilaxia (arteriolopatia urêmica calcificante). A varfarina, aliás, é fator de risco para ela, por inibir a proteína Gla da matriz, e costuma ser trocada. Pulsos presentes e ausência de procedimento vascular e eosinofilia falam contra embolia de colesterol.

A) Necrose cutânea induzida pela varfarina ARMADILHA
Errada. É a isca; seria o diagnóstico nos primeiros 3 a 10 dias depois de iniciar a varfarina, e ela usa a droga há dois anos.

B) Embolia de colesterol
Errada. Embolia de colesterol vem depois de cateterismo ou anticoagulação recente, com livedo distal, dedos azuis e eosinofilia, ausentes aqui.

C) Arteriolopatia urêmica calcificante CORRETA
Correta. Dialítica com fósforo e PTH altos, cálcio exógeno e varfarina, com placas dolorosas que necrosam em áreas de gordura.

D) Vasculite cutânea de pequenos vasos
Errada. Vasculite daria púrpura palpável, em geral distal, com marcadores ou causa associada; ANCA, FAN e crioglobulinas são negativos.

Para levar. Necrose cutânea dolorosa em áreas de gordura no paciente em diálise é calcifilaxia; a necrose pela varfarina é dos primeiros dias de uso, e a varfarina crônica é fator de risco da calcifilaxia.

Nigwekar SU et al. Calciphylaxis. N Engl J Med 2018; KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for CKD-MBD.

8

Hematologia · Mulher de família com hemofilia B, com menorragia e TTPa normal antes de cirurgia: dosar o fator IX

Negativo no meio | Gabarito A

Mulher de 28 anos será submetida a colecistectomia videolaparoscópica eletiva. O irmão e um tio materno têm hemofilia B grave. Relata menorragia desde a menarca, com ferropenia tratada duas vezes, e sangramento prolongado após exodontia aos 19 anos. Nega uso de medicamentos. Exame físico sem equimoses. Exames: Hb 12,4 g/dL, plaquetas 260.000/mm³, TP normal, TTPa de 33 segundos (VR 25 a 35), fibrinogênio 280 mg/dL. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE
TTPa de 33 segundos (VR 25 a 35)

Resolução. TTPa normal costuma ser lido como garantia de hemostasia, e aqui ele tranquiliza. Mas o TTPa só se alonga quando o fator IX cai abaixo de cerca de 30% a 40%, e portadoras de hemofilia B podem ter fator IX entre 20% e 50% (por inativação desigual do X) com sangramento real: menorragia, sangramento pós-exodontia e pós-cirúrgico. Ela é portadora obrigatória? Não necessariamente, mas é filha de mãe portadora provável (irmão e tio materno afetados), com 50% de chance de ser portadora, e já tem fenótipo hemorrágico. Antes de uma cirurgia, o exame que muda a conduta é a dosagem da atividade do fator IX: se baixa, o preparo é com concentrado de fator IX e antifibrinolítico. O estudo genético define o estado de portadora para aconselhamento reprodutivo, mas não informa o risco de sangramento; a pesquisa de von Willebrand cabe a menorragia sem história familiar sugestiva.

A) Dosagem da atividade do fator IX CORRETA

Correta. Possível portadora de hemofilia B com fenótipo hemorrágico: dosar o fator IX antes da cirurgia, porque o TTPa pode ser normal.

B) Fator de von Willebrand e fator VIII

Errada. Seria o exame de menorragia sem história familiar de hemofilia; aqui a história aponta o fator IX.

C) Sequenciamento do gene F9 isolado

Errada. Define o estado de portadora, mas não o nível do fator, que é o que orienta o preparo cirúrgico.

D) Nenhum, TTPa normal libera a cirurgia ARMADILHA

Errada, é a armadilha. TTPa normal não exclui fator IX de 30% a 40%, nível que sangra em cirurgia.

Para levar. Portadora de hemofilia pode sangrar com TTPa normal: em mulher de família afetada, dosar o fator antes de procedimento.

WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3ª edição (2020); ISTH, nomenclatura de mulheres e meninas com hemofilia (van Galen et al., J Thromb Haemost 2021).

9

Medicina Baseada em Evidências · Ensaio de superioridade com cruzamento entre grupos: intenção de tratar como análise primária, com viés para o nulo

Qualificador **Gabarito C**

Um ensaio de superioridade randomizou 1.000 pacientes com fibrilação atrial para ablação por cateter (500) ou drogas antiarrítmicas (500). Por falha técnica ou preferência, 90 do grupo ablação não foram ablacionados e 60 do grupo drogas cruzaram para ablação. O desfecho primário é morte ou AVC em 4 anos. A análise primária mais adequada e o efeito do cruzamento sobre ela são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Um ensaio de superioridade

Resolução. Excluir quem cruzou parece limpar a comparação, e a análise por protocolo atrai. Mas quem não recebeu a ablação ou cruzou não é aleatório (mais doentes, mais sintomáticos, com anatomia difícil), e excluí-los ou realocá-los quebra a randomização e reintroduz confusão. A análise por intenção de tratar mantém cada paciente no grupo sorteado e preserva a comparabilidade, estimando o efeito da estratégia de oferecer a ablação. O preço é que o cruzamento torna os grupos mais parecidos e dilui a diferença, aproximando o resultado do nulo; num ensaio de superioridade isso é conservador (dificulta mostrar benefício), por isso ela é a análise primária. No ensaio de não inferioridade o mesmo viés favorece concluir não inferioridade, e as duas análises devem concordar.

A) Por protocolo / nenhum, pois exclui os cruzados ARMADILHA

Errada. Exclui pacientes não aleatórios e quebra a randomização; não elimina o viés, troca-o por confusão.

B) Tratamento recebido / aproxima do nulo

Errada. Agrupar pelo tratamento recebido também quebra a randomização; é análise observacional dentro do ensaio.

C) Intenção de tratar / aproxima do nulo CORRETA

Correta. Superioridade: intenção de tratar preserva a randomização, e o cruzamento dilui o efeito em direção ao nulo.

D) Intenção de tratar / afasta do nulo

Errada. O cruzamento torna os grupos parecidos e reduz a diferença; não a aumenta.

Para levar. Intenção de tratar preserva a randomização; cruzamento e baixa adesão puxam o resultado para o nulo. Em superioridade isso é conservador; em não inferioridade favorece a conclusão errada, por isso se exige concordância com a análise por protocolo.

CONSORT 2025 Statement; ICH E9(R1) Addendum on estimands (2019); Hernán MA, Robins JM, Per-protocol analyses of pragmatic trials, NEJM 2017.

---

10 Endocrinologia · Graves em metimazol 20 mg com TRAb alto e gestação de 5 semanas: trocar por propiltiouracil e manter o T4 livre no limite superior

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 30 anos, com doença de Graves diagnosticada há 8 meses, em uso de metimazol 20 mg/dia (duas tentativas de reduzir para 10 mg levaram a recaída), descobre gestação de 5 semanas, não planejada. Bócio difuso, FC 88 bpm, sem orbitopatia ativa. Exames: T4 livre 1,7 ng/dL (referência 0,9 a 1,8), TSH 0,02 mUI/L, TRAb 14 UI/L (referência até 1,75), função hepática e hemograma normais. Quanto ao antitireoidiano agora e ao alvo laboratorial do tratamento, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

duas tentativas de reduzir para 10 mg levaram a recaída

Resolução. A diretriz permite considerar suspender o antitireoidiano ao descobrir a gestação, e isso atrai quem lembra da teratogenicidade, sendo a armadilha; mas a suspensão vale para quem está eutireoidiana com dose baixa (metimazol até 5 a 10 mg) e baixo risco de recaída. Aqui ela precisa de 20 mg, recaiu duas vezes ao reduzir e tem TRAb muito alto: suspender levaria a tireotoxicose no primeiro trimestre. O metimazol, entre 6 e 10 semanas, associa-se a embriopatia (aplasia cútis, atresia de cóanas e de esôfago), por isso troca-se pelo propiltiouracil no primeiro trimestre. O alvo é a menor dose que mantenha o T4 livre materno no limite superior da referência ou pouco acima, aceitando TSH suprimido; normalizar o TSH materno indica excesso de droga, que atravessa a placenta e causa hipotireoidismo e bócio fetal.

A) Manter o metimazol / T4 livre no meio da referência

Errada. Manter o metimazol no primeiro trimestre expõe à embriopatia, e o alvo no meio da referência é tratamento em excesso.

B) Suspender o antitireoidiano / repetir em 2 semanas ARMADILHA

Errada. É a armadilha: suspender é opção só com dose baixa e baixo risco de recaída; com 20 mg, recaídas e TRAb alto, ela ficaria tireotóxica.

C) Trocar por propiltiouracil / TSH dentro da referência

Errada. A droga está certa, mas buscar TSH normal significa dose excessiva e hipotireoidismo fetal.

D) Trocar por propiltiouracil / T4 livre no limite superior CORRETA

Correta. Propiltiouracil no primeiro trimestre, na menor dose que mantenha o T4 livre no limite superior da referência.

Para levar. Graves na gestação: propiltiouracil no primeiro trimestre (metimazol é teratogênico entre 6 e 10 semanas), e o alvo é T4 livre materno no limite superior, com TSH ainda suprimido.

ATA 2017 (Guidelines for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum); ETA 2018 (Graves' hyperthyroidism).

---

11 Infectologia · Eritema nodoso hansênico em mulher que planeja engravidar: prednisona, e não talidomida

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 26 anos trata hanseníase virchowiana com poliquimioterapia multibacilar há 6 meses, com boa adesão. Há 5 dias surgiram nódulos eritematosos, quentes e dolorosos nos braços e coxas, febre de 38,5 °C, mal-estar, artralgia de joelhos e dor à palpação do nervo ulnar direito, sem perda de força. Não usa contraceptivo, porque ela e o marido planejam engravidar nos próximos meses, e recusa métodos contraceptivos. β-hCG negativo. Hemograma: leucocitose de 13.800/mm³ com neutrofilia; função renal e hepática normais. A conduta mais adequada para a reação, mantendo a poliquimioterapia, é:

O DADO QUE DECIDE

planejam engravidar nos próximos meses

Resolução. Eritema nodoso hansênico (reação tipo 2) tem a talidomida como droga de escolha no PCDT, e esse é o rótulo verdadeiro que atrai. Mas a talidomida é teratogênica com uma única dose, e seu uso em mulher em idade fértil exige dois métodos contraceptivos e controle rigoroso, o que esta paciente recusa e contraria o plano de gestar. Nesse cenário, e também porque há neurite (dor no ulnar), a escolha é prednisona 1 mg/kg/dia, com desmame lento conforme a resposta. A clofazimina em dose alta e a pentoxifilina são alternativas ou poupadoras de corticoide em casos crônicos, e não tratam isoladamente um surto agudo com neurite. A poliquimioterapia é mantida: a reação não indica suspender o tratamento.

A) Talidomida 100 a 300 mg/dia ARMADILHA

Errada. É a armadilha: é a primeira escolha no eritema nodoso hansênico em homens e mulheres sem potencial de gestar, mas é teratogênica e contraindicada aqui.

B) Clofazimina em dose alta, isolada

Errada. A clofazimina em dose alta é poupadora de corticoide na reação tipo 2 crônica ou recorrente, de início lento, e não basta isolada no surto com neurite.

C) Prednisona 1 mg/kg/dia CORRETA

Correta. Na mulher que pode engravidar, e com neurite associada, a prednisona é o tratamento da reação tipo 2.

D) Pentoxifilina, isolada

Errada. A pentoxifilina é alternativa adjuvante em quadros leves, sem eficácia suficiente isolada na reação com neurite.

Para levar. Na reação tipo 2 da hanseníase, talidomida é a primeira escolha, exceto na mulher em idade fértil sem contracepção segura: aí, e sempre que há neurite, prednisona.

Ministério da Saúde, PCDT Hanseníase (2022); Guia prático sobre a hanseníase (2017); Lei 10.651/2003 e RDC ANVISA 11/2011 (talidomida).

---

12 Neurologia · Mioclonias e confusão na dialítica em uso de cefalosporina antipseudomonas sem ajuste: neurotoxicidade pela cefepima, não uremia

Droga a deduzir **Gabarito C**

Mulher de 72 anos, em hemodiálise três vezes por semana, está internada há 5 dias por pneumonia hospitalar e recebe desde a admissão uma cefalosporina com cobertura para Pseudomonas e para cocos Gram-positivos, prescrita na dose de 2 g de 8 em 8 horas, igual à de um paciente com função renal normal, sem ajuste. Há 2 dias está confusa e hoje tem mioclonias multifocais e fala desconexa. Afebril há 48 horas, PA 132/76 mmHg, glicemia 110 mg/dL, sódio 138 mEq/L, cálcio normal, ureia pré-diálise de 98 mg/dL, estável em relação à basal. TC de crânio sem lesões agudas. EEG: ondas trifásicas e descargas periódicas generalizadas. Líquor: 2 células/mm³, glicose e proteína normais. A causa mais provável do quadro é:

> **O DADO QUE DECIDE**
>
> *prescrita na dose de 2 g de 8 em 8 horas, igual à de um paciente com função renal normal, sem ajuste*

Resolução. Paciente dialítica com confusão, mioclonias e ondas trifásicas soa como uremia, e é a armadilha; mas a ureia está estável na basal e ela segue em diálise regular. A droga não é nomeada: cefalosporina com cobertura para Pseudomonas e para Gram-positivos é a cefepima (de quarta geração), aqui em dose plena, a de rim normal, numa paciente anúrica. A cefepima se acumula na insuficiência renal, atravessa a barreira e antagoniza o receptor GABA-A, causando encefalopatia com mioclonias, ondas trifásicas, descargas periódicas e até estado de mal não convulsivo, em geral 2 a 6 dias após o início. A conduta é suspender ou trocar o antibiótico e aumentar a remoção com hemodiálise, além de benzodiazepínico se houver estado de mal. A pneumonia está melhorando (afebril há 48 horas), e o líquor normal afasta a encefalite.

A) Encefalopatia urêmica ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Encefalopatia urêmica seria a hipótese com ureia subindo ou diálise inadequada; aqui a ureia está estável na basal.

B) Encefalite herpética
Errada. Encefalite herpética daria febre, pleocitose no líquor e lesão temporal; o líquor é acelular.

C) Neurotoxicidade pela cefepima CORRETA
Correta. Dose de rim normal numa paciente em hemodiálise, com mioclonias, ondas trifásicas e descargas periódicas no 3º ao 5º dia: neurotoxicidade da cefepima.

D) Encefalopatia associada à sepse
Errada. Encefalopatia da sepse acompanharia a infecção ativa; ela está afebril e melhorando, e as mioclonias com descargas periódicas apontam toxicidade.

Para levar. Encefalopatia com mioclonias e descargas periódicas em paciente renal usando betalactâmico, sobretudo cefepima: pense em neurotoxicidade, suspenda e dialise.

FDA Drug Safety Communication: cefepime and risk of seizure in patients not receiving dosage adjustments for kidney impairment (2012); Payne LE et al. Cefepime-induced neurotoxicity: a systematic review. Crit Care 2017.

---

13 Oncologia · Câncer de pâncreas irressecável com icterícia antes de quimioterapia: prótese metálica autoexpansível por CPRE

Grade X / Y **Gabarito C**

Homem de 69 anos, com adenocarcinoma de cabeça de pâncreas que envolve 270 graus da artéria mesentérica superior (localmente avançado e irressecável), sem metástases, ECOG 1, apresenta icterícia com bilirrubina de 14 mg/dL e prurido, sem febre ou colangite. A oncologia programa quimioterapia com FOLFIRINOX, com expectativa de vida estimada em mais de 6 meses. O tipo de prótese biliar e a via de colocação mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

com expectativa de vida estimada em mais de 6 meses

Resolução. A prótese plástica por CPRE é a mais lembrada, barata e fácil de trocar, e atrai. Mas na obstrução biliar distal maligna com expectativa de vida acima de 3 meses, especialmente quando a quimioterapia vai começar, a prótese metálica autoexpansível é preferida: permanece pérvia por muito mais tempo, reduz colangite e reintervenções e evita interrupções da quimioterapia por oclusão. A via de escolha é a endoscópica (CPRE), com menos complicações e mais conforto que a drenagem percutânea, que fica para falha ou impossibilidade da CPRE (por exemplo, obstrução duodenal ou anatomia alterada). Drenar antes do FOLFIRINOX é necessário, porque a quimioterapia exige bilirrubina próxima do normal.

A) Metálica / via percutânea
Errada. A prótese está certa, mas a via percutânea (ou a drenagem guiada por ecoendoscopia) é para falha ou impossibilidade da CPRE.

B) Plástica / via percutânea
Errada. Prótese plástica e via percutânea: as duas escolhas inferiores para este paciente.

C) Metálica / via endoscópica (CPRE) CORRETA
Correta. Obstrução distal maligna com sobrevida esperada acima de 3 meses e quimioterapia programada: prótese metálica autoexpansível por CPRE.

D) Plástica / via endoscópica (CPRE) ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a plástica oclui em poucos meses, causa colangite e interrompe a quimioterapia; serve para sobrevida curta ou diagnóstico incerto.

Para levar. Obstrução biliar distal maligna: prótese metálica autoexpansível por CPRE quando a sobrevida esperada passa de 3 meses; via percutânea só se a CPRE falhar.

ESGE Guideline: Endoscopic biliary stenting: indications, choice of stents, and results (2018); NCCN Pancreatic Adenocarcinoma (2025)

---

14 Cardiologia · ICFEr otimizada com cansaço persistente e anemia leve: pesquisar ferropenia com ferritina e saturação de transferrina antes de qualquer outro exame

Omissão **Gabarito D**

Homem de 64 anos, com cardiomiopatia isquêmica (FE 30%) e angioplastia de descendente anterior há 3 anos, está há 6 meses com sacubitril-valsartana, bisoprolol, espironolactona e dapagliflozina em doses máximas toleradas. Sem angina; persiste com cansaço aos médios esforços, em classe funcional II a III. PA 104×66 mmHg, FC 62 bpm, sem congestão. Hb 12,4 g/dL (referência 13 a 17), VCM 84 fL, plaquetas normais; creatinina 1,3 mg/dL, potássio 4,8 mEq/L, NT-proBNP 1.100 pg/mL. Sem sangramento visível; colonoscopia de rastreio há 2 anos normal. O cardiologista anterior anotou 'anemia leve da doença crônica, sem necessidade de investigação'. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

persiste com cansaço aos médios esforços, em classe funcional II a III

Resolução. O degrau mais simples, e o que falta na história, é o perfil de ferro, e o rótulo de anemia da doença crônica serve exatamente para dispensá-lo. Na insuficiência cardíaca, a deficiência de ferro é comum (até metade dos pacientes, com ou sem anemia), reduz a capacidade de exercício e a qualidade de vida, e se define por critérios próprios: ferritina abaixo de 100 ng/mL, ou entre 100 e 299 ng/mL com saturação de transferrina abaixo de 20%. A diretriz europeia recomenda dosar ferritina e saturação em todo paciente com IC e, se houver deficiência, ferro intravenoso (carboximaltose ou derivisomaltose férrica) para sintomas e redução de internações. A endoscopia é o degrau seguinte, justificado se a ferropenia for confirmada num homem, e por isso é a isca de quem pula o primeiro passo. Sem angina e com tratamento otimizado, o cateterismo não está indicado para explicar cansaço.

A) Aspirado de medula óssea
Errada. O aspirado de medula fica para citopenias múltiplas ou anemia sem explicação após a investigação básica; aqui só há anemia leve normocítica sem outra alteração.

B) Endoscopia digestiva alta e colonoscopia ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. A investigação digestiva vem depois de confirmar ferropenia num homem; pedi-la antes do perfil de ferro é pular o degrau.

C) Cineangiocoronariografia
Errada. O cateterismo seria indicado por angina ou isquemia documentada; ele não tem angina e a revascularização não explica nem trata o cansaço aqui.

D) Ferritina e saturação de transferrina CORRETA
Correta. Toda IC sintomática deve ter ferritina e saturação dosadas, e a ferropenia (ferritina abaixo de 100, ou 100 a 299 com saturação abaixo de 20%) tem tratamento com ferro intravenoso.

Para levar. Na insuficiência cardíaca, dose ferritina e saturação de transferrina em todos: ferritina abaixo de 100, ou de 100 a 299 com saturação abaixo de 20%, é ferropenia, tratada com ferro intravenoso; investigar a causa vem depois.

ESC 2023 Focused Update of the 2021 Heart Failure Guidelines; Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca SBC 2018 e atualização 2021; estudos AFFIRM-AHF (2020) e IRONMAN (2022)

15 Reumatologia · Prevenção da osteonecrose dos maxilares antes de antirreabsortivo em dose oncológica: avaliação e tratamento odontológico antes da primeira dose

Qualificador **Gabarito A**

Antes de iniciar ácido zoledrônico mensal para metástases ósseas de câncer de mama, a medida com maior respaldo para reduzir o risco de osteonecrose dos maxilares é:

O DADO QUE DECIDE

a medida com maior respaldo

Resolução. A dosagem do CTX sérico antes de procedimentos orais ficou popular como forma de medir o risco e atrai por parecer objetiva, mas não tem validação para prever osteonecrose e não é recomendada. O risco de osteonecrose dos maxilares é muito maior com doses oncológicas de zoledronato ou denosumabe do que com doses para osteoporose, e o principal gatilho é procedimento dentoalveolar (extração) durante o tratamento. A medida com maior respaldo é examinar e tratar a boca antes da primeira dose: extrair dentes sem prognóstico, tratar focos infecciosos, ajustar próteses, e manter higiene e revisões periódicas, evitando extrações durante o uso. Interromper o tratamento oncológico de forma programada não tem respaldo e expõe a eventos esqueléticos.

A) Avaliação e tratamento odontológico antes de iniciar CORRETA
Correta. Resolver a doença dentária antes da primeira dose é a medida preventiva que reduz o risco.

B) Antibiótico profilático a cada infusão
Errada. Antibiótico profilático rotineiro não tem respaldo na prevenção primária.

C) Dosar CTX sérico antes de cada procedimento oral ARMADILHA
Errada. O CTX sérico não prevê osteonecrose e não é recomendado para estratificar risco.

D) Intercalar meses sem o fármaco
Errada. Interrupção programada na dose oncológica não tem evidência de benefício e aumenta eventos ósseos.

Para levar. Antes de antirreabsortivo em dose oncológica, trate a boca antes da primeira dose; CTX sérico e pausas programadas não têm respaldo.

AAOMS Position Paper on Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws (2022 update); MASCC/ISOO/ASCO Clinical Practice Guideline on MRONJ (2019).

---

16 Hematologia · Hipereosinofilia com triptase alta, B12 muito alta e fibrose endomiocárdica, sem agregados de mastócitos: neoplasia mieloide com FIP1L1::PDGFRA, e não mastocitose sistêmica

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 42 anos com dispneia progressiva e edema há 4 meses. Eosinófilos de 6.800/mm³ e de 7.200/mm³ em dois hemogramas com 6 semanas de intervalo, sem queda após ivermectina empírica. Nega asma, rinite ou uso de medicamentos novos. Exame: baço a 5 cm do rebordo costal, sem lesões de pele, sem urticária ao atrito. Ecocardiograma: obliteração do ápice do ventrículo esquerdo por material ecogênico e padrão restritivo. Exames: Hb 12,9 g/dL, plaquetas 160.000/mm³, vitamina B12 sérica 2.900 pg/mL (VR 200 a 900), triptase sérica

28 ng/mL (VR até 11,4), IgE normal, ANCA negativo, sorologia para Strongyloides e parasitológico de fezes seriado negativos. Biópsia de medula: hipercelular, com eosinófilos maduros abundantes e mastócitos fusiformes dispersos, sem agregados compactos de mastócitos. A etiologia mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

mastócitos fusiformes dispersos, sem agregados compactos de mastócitos

Resolução. Triptase sérica elevada com mastócitos fusiformes na medula é um rótulo verdadeiro que puxa para mastocitose sistêmica, que também pode cursar com eosinofilia e esplenomegalia. Mas o critério maior da mastocitose são os agregados multifocais compactos de mastócitos na medula, ausentes aqui, e não há lesão cutânea; a triptase de 28 ng/mL é apenas moderada. O conjunto pesa para o outro lado: hipereosinofilia acentuada e persistente em homem, esplenomegalia, vitamina B12 sérica muito alta (pela transcobalamina dos granulócitos em expansão clonal) e lesão de órgão grave (fibrose endomiocárdica com obliteração apical, a endocardite de Löffler). É a assinatura da neoplasia mieloide com rearranjo FIP1L1::PDGFRA, em que a triptase sobe e os mastócitos fusiformes aparecem sem formar agregados; a pesquisa se faz por FISH ou RT-PCR no sangue. O diagnóstico importa porque a doença responde de forma dramática a imatinibe em dose baixa. A síndrome hipereosinofílica idiopática só se aceita depois de afastar o rearranjo, e a EGPA exigiria asma.

A) Granulomatose eosinofílica com poliangeíte
Errada. Exigiria asma (quase universal na EGPA), sinusite ou vasculite; não há asma e o ANCA é negativo.

B) Síndrome hipereosinofílica idiopática
Errada. É diagnóstico de exclusão; B12 e triptase altas com esplenomegalia apontam um clone mieloide a pesquisar antes.

C) Neoplasia mieloide com FIP1L1::PDGFRA CORRETA
Correta. Hipereosinofilia com esplenomegalia, B12 muito alta, triptase moderada e mastócitos fusiformes sem agregados, com fibrose endomiocárdica: FIP1L1::PDGFRA, sensível a imatinibe.

D) Mastocitose sistêmica ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria a resposta com agregados compactos de mastócitos na medula ou lesões cutâneas; triptase moderada e mastócitos dispersos acompanham o rearranjo de PDGFRA.

Para levar. Hipereosinofilia com esplenomegalia, B12 muito alta e triptase moderadamente elevada, sem agregados de mastócitos, é neoplasia mieloide com FIP1L1::PDGFRA até prova em contrário: pesquisar o rearranjo, porque responde a imatinibe.

Shomali W, Gotlib J, World Health Organization-defined eosinophilic disorders: 2024 update (Am J Hematol 2024); Classificação OMS de neoplasias hematolinfoides, 5ª edição (2022).

---

17 Infectologia · Tosse paroxística há 3 semanas com vômito pós-tosse e linfocitose, sem febre e com radiografia normal, no adulto vacinado na infância: coqueluche

Negativo no meio | Gabarito D

Mulher de 34 anos, professora do ensino infantil, vacinada na infância e sem reforços desde então, tem tosse há 3 semanas. Começou com coriza e tosse leve; há 2 semanas, a tosse vem em acessos, pior à noite, terminando com guincho inspiratório e, às vezes, com vômito logo após os acessos, ficando bem entre eles. Nega febre.

Exame: T 36,7 °C, SpO2 98%, ausculta pulmonar normal, hemorragia subconjuntival à direita. Radiografia de tórax normal. Hemograma: leucócitos 14.800/mm³ com 62% de linfócitos. A irmã, que mora com ela, tem um bebê de 6 semanas. O agente mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

vômito logo após os acessos

Resolução. Tosse que começou com coriza, sem febre, com ausculta e radiografia normais, num adulto que está bem entre os episódios, é o retrato da tosse pós-viral, e o diagnóstico de rinovírus atrai. Mas a vacina da infância não protege o adulto décadas depois, e os dados que separam são os do acesso: tosse paroxística com guincho, vômito logo após os acessos, hemorragia subconjuntival pelo esforço e paciente assintomático entre as crises, com linfocitose absoluta (efeito da toxina pertussis). A fase paroxística começa cerca de 1 a 2 semanas depois da fase catarral, como aqui. O diagnóstico importa pelo contato: lactente de 6 semanas, ainda não protegido, tem alto risco de coqueluche grave, e deve receber quimioprofilaxia com azitromicina, assim como a paciente deve ser tratada e afastada até 5 dias de antibiótico. O Mycoplasma dá febre baixa, cefaleia e infiltrado, e o adenovírus, febre e conjuntivite.

A) Rinovírus, com tosse pós-viral ARMADILHA

Errada. É a armadilha: a tosse pós-viral não tem guincho, vômito pós-acesso nem linfocitose de 62%.

B) Mycoplasma pneumoniae

Errada. O Mycoplasma causa febre, cefaleia, mal-estar e frequentemente infiltrado radiológico, e não acessos com guincho e linfocitose.

C) Adenovírus

Errada. O adenovírus cursa com febre, faringite e conjuntivite folicular, e não com fase paroxística de semanas.

D) Bordetella pertussis CORRETA

Correta. Acessos com guincho, vômito pós-tosse, hemorragia subconjuntival, bem entre as crises e linfocitose, após fase catarral, são coqueluche.

Para levar. Tosse em acessos com guincho, vômito pós-tosse e linfocitose, sem febre e com radiografia normal, é coqueluche mesmo no adulto vacinado na infância; tratar e fazer profilaxia nos contatos vulneráveis.

Ministério da Saúde, Guia de Vigilância em Saúde, 6ª ed. (2023), coqueluche; CDC, Pertussis: clinical overview (2024).

---

18 Oncologia · Vacina contra HPV na transplantada renal de 33 anos: indicada pelo PNI até 45 anos, em três doses

Limiar Gabarito B

Mulher de 33 anos, transplantada renal em uso de tacrolimo e micofenolato, nunca vacinada contra HPV, pergunta se pode receber a vacina pelo SUS. Segundo o Programa Nacional de Imunizações, a conduta é:

O DADO QUE DECIDE

transplantada renal

Resolução. Duas armadilhas competem. A primeira é achar que imunossuprimido não pode receber vacina, mas a vacina contra HPV é inativada (partículas semelhantes ao vírus) e é segura. A segunda é a mudança recente do PNI para dose única, que vale para a faixa etária de rotina de adolescentes. Para imunossuprimidos (transplantados de órgão sólido ou de medula, pessoas vivendo com HIV, pacientes oncológicos em tratamento), o PNI amplia a idade de 9 até 45 anos e mantém o esquema de três doses (0, 2 e 6 meses), porque a resposta imune é menor. A transplantada tem risco aumentado de câncer de colo, anal e de outros sítios relacionados ao HPV, e o rastreio do colo segue também em intervalo encurtado.

A) Não vacinar: contraindicada no imunossuprimido
Errada. A vacina é inativada e segura em imunossuprimidos; o PNI a recomenda justamente nesse grupo.

B) Vacinar com três doses (0, 2 e 6 meses) CORRETA
Correta. Imunossuprimidos de 9 a 45 anos: três doses, em 0, 2 e 6 meses.

C) Vacinar com dose única ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a dose única vale para a rotina de adolescentes imunocompetentes; o imunossuprimido mantém três doses.

D) Não vacinar: idade acima do limite
Errada. Para imunossuprimidos o limite é 45 anos; aos 33 anos ela está dentro.

Para levar. HPV no imunossuprimido (transplante, HIV, oncológico): vacinar de 9 a 45 anos, sempre com três doses.

Ministério da Saúde: Calendário Nacional de Vacinação e Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (6ª edição, 2023); Nota Técnica do PNI sobre esquema da vacina HPV (2024)

19

Pneumologia · Pneumonia comunitária com CURB-65 baixo e quatro critérios menores da ATS/IDSA: terapia intensiva

Rótulo verdadeiro

Gabarito B

Mulher de 64 anos, previamente hígida, tem febre, tosse e dispneia há 3 dias. Está lúcida e orientada. PA 108/66 mmHg, FR 32 irpm, temperatura 38,6 °C, SpO2 89% em ar ambiente; PaO2 62 mmHg com FiO2 de 0,28 (relação PaO2/FiO2 de 221). Radiografia: consolidações nos lobos inferior direito, médio e inferior esquerdo. Ureia 38 mg/dL, leucócitos 3.200/mm³, plaquetas 180.000/mm³. CURB-65 calculado na triagem: 1. O local de tratamento mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

leucócitos 3.200/mm³

Resolução. O CURB-65 de 1 está certo (só a frequência respiratória pontua) e é o rótulo verdadeiro que leva à enfermaria ou até ao domicílio. Mas o CURB-65 estima mortalidade, não necessidade de terapia intensiva, e subestima a gravidade em quem tem hipoxemia e leucopenia. Para decidir UTI, a diretriz usa os critérios da ATS/IDSA: um maior (choque com vasopressor ou ventilação mecânica) ou três ou mais menores. Esta paciente tem quatro menores: frequência respiratória de 30 ou mais, PaO2/FiO2 de 250 ou menos, infiltrado multilobar e leucopenia abaixo de 4.000 (que indica pior prognóstico, muitas vezes pneumococo grave). A internação em UTI precoce, antes de deteriorar, reduz mortalidade.

A) Domicílio, com reavaliação em 48 horas
Errada. Seria o destino com CURB-65 de 0 a 1 sem hipoxemia nem critérios de gravidade.

B) Unidade de terapia intensiva CORRETA
Correta. Quatro critérios menores da ATS/IDSA (FR 32, PaO2/FiO2 221, multilobar, leucopenia): PAC grave, terapia intensiva.

C) Enfermaria, com reavaliação em 48 horas ARMADILHA
Errada. É o que o CURB-65 sugere, mas ele não mede necessidade de UTI e ignora a leucopenia e a hipoxemia.

D) Observação na emergência por 24 horas
Errada. Adia uma decisão já definida pelos critérios de gravidade.

Para levar. CURB-65 decide internar ou não; para UTI use ATS/IDSA: um critério maior ou três menores (FR de 30 ou mais, PaO2/FiO2 de 250 ou menos, multilobar, confusão, ureia de 43 mg/dL ou mais, leucócitos abaixo de 4.000, plaquetas abaixo de 100.000, temperatura abaixo de 36 °C, hipotensão que exige volume).

ATS/IDSA Guideline for Community-acquired Pneumonia in Adults (2019); Diretrizes Brasileiras para PAC em Adultos, SBPT (2018).

20

Nefrologia · Acidose com ânion gap alto, lactato e cetonas normais na idosa desnutrida em paracetamol regular: 5-oxoprolina, e não sepse

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 74 anos, com 41 kg, desnutrida e com doença renal crônica estágio 3b, está internada há 3 semanas por infecção de prótese de quadril por Staphylococcus aureus sensível, em oxacilina intravenosa, com hemoculturas de controle negativas desde o 4º dia e febre resolvida. Recebe paracetamol 1 g de 6 em 6 horas desde a admissão, por dor. Há 2 dias está confusa, com respiração profunda. Afebril, PA 118 × 70 mmHg, FC 92 bpm. Exames: pH 7,19, pCO2 21 mmHg, bicarbonato 8 mEq/L, sódio 138 mEq/L, cloro 104 mEq/L, glicose 96 mg/dL, lactato 1,4 mmol/L, beta-hidroxibutirato 0,3 mmol/L, creatinina 1,5 mg/dL (basal 1,4), ureia 64 mg/dL, osmolalidade medida de 296 e calculada de 292 mOsm/kg, ALT 22 U/L, paracetamol sérico 9 µg/mL, procalcitonina 0,2 ng/mL. A causa mais provável da acidose é:

O DADO QUE DECIDE

lactato 1,4 mmol/L, beta-hidroxibutirato 0,3 mmol/L

Resolução. A infecção de prótese é verdadeira e, numa idosa confusa com acidose grave, a sepse é o primeiro pensamento. Mas o ânion gap de 26 precisa de um ânion que o explique, e os candidatos de manual foram medidos: lactato de 1,4 mmol/L, beta-hidroxibutirato de 0,3 mmol/L, gap osmolar de 4 mOsm/kg (afasta álcoois tóxicos) e uma DRC estável que não produz gap desse tamanho. A febre resolvida, as hemoculturas negativas e a procalcitonina baixa também falam contra sepse. Paracetamol em dose plena e contínua por semanas, em mulher idosa, desnutrida, com DRC e infecção, depleta glutationa e acumula ácido piroglutâmico (5-oxoprolina), causa de acidose com ânion gap alto que não aparece nos exames de rotina. A confirmação é a dosagem de ácidos orgânicos na urina, e a conduta é suspender o paracetamol, com N-acetilcisteína como opção para repor glutationa.

A) Acidose lática por sepse ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Seria a causa com lactato elevado em paciente séptico; aqui o lactato é de 1,4 mmol/L, a febre cedeu e a procalcitonina é baixa.

B) Cetoacidose de jejum

Errada. A desnutrição sugere jejum, mas a cetoacidose de jejum é leve e teria beta-hidroxibutirato elevado; ele é de 0,3 mmol/L.

C) Intoxicação por etilenoglicol

Errada. Daria gap osmolar alto e lesão renal aguda; o gap osmolar é de 4 mOsm/kg e a creatinina está estável.

D) Acidose por 5-oxoprolina CORRETA

Correta. Ânion gap de 26 sem lactato, cetonas ou álcoois, em idosa desnutrida com DRC sob paracetamol regular: acidose por 5-oxoprolina.

Para levar. Ânion gap alto sem lactato, cetonas, uremia avançada ou gap osmolar, em quem toma paracetamol regular e é desnutrido, idoso ou séptico: pense em 5-oxoprolina e suspenda o paracetamol.

Emmett M, Acetaminophen toxicity and 5-oxoproline (pyroglutamic acid): a tale of two cycles, Clin J Am Soc Nephrol 2014; Fenves AZ et al., Clin J Am Soc Nephrol 2006.

21

Endocrinologia · Cetoacidose resolvida em paciente que já se alimenta: glargina subcutânea agora, mantendo a insulina venosa por mais 2 horas

Cronologia **Gabarito B**

Homem de 23 anos, com diabetes tipo 1 há 6 anos (glargina 22 U às 22 horas e lispro nas refeições), foi admitido com cetoacidose após 2 dias sem insulina por ter perdido a caneta. Recebeu hidratação, potássio e insulina regular venosa contínua. Após 14 horas: glicemia 186 mg/dL, pH 7,34, bicarbonato 19 mEq/L, cetonemia 0,4 mmol/L, potássio 4,2 mEq/L; está lúcido, sem náuseas, e aceitou o café da manhã às 8 horas. A infusão está em 3 U/h, e a enfermagem pergunta se pode desligar a bomba agora. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

glargina 22 U às 22 horas

Resolução. A cetoacidose está resolvida (pH acima de 7,3, bicarbonato acima de 18, cetonemia abaixo de 0,6) e ele come: é hora de passar para insulina subcutânea, e o erro é de ordem. A insulina regular venosa tem meia-vida de minutos; se a bomba for desligada antes de haver insulina basal subcutânea agindo, em 1 a 2 horas falta insulina e a cetogênese recomeça, que é o rebote de cetoacidose. Por isso a basal subcutânea deve ser feita antes, com sobreposição de 2 a 4 horas com a infusão, e só então a bomba é desligada. Ele está sem glargina há mais de 2 dias; esperar o horário das 22 horas deixaria 14 horas sem basal subcutânea ou mais 14 horas de bomba com ele se alimentando. Fazer a glargina agora, com a dose habitual, e reajustar o horário nos dias seguintes resolve as duas coisas.

A) Desligar a bomba e fazer lispro no café

Errada. Lispro cobre a refeição, mas sem basal subcutânea a cetogênese volta horas depois de desligar a infusão.

B) Glargina agora e bomba por mais 2 horas CORRETA

Correta. Basal subcutânea primeiro e sobreposição de cerca de 2 horas com a infusão antes de desligá-la evitam o rebote.

C) Manter a bomba até a glargina das 22 horas

Errada. Não há rebote, mas prolonga sem necessidade a infusão venosa, com monitorização horária, num paciente que já come.

D) Desligar a bomba e retomar a glargina às 22 horas ARMADILHA

Errada. É a armadilha: desligar a bomba sem basal agindo deixa 14 horas sem insulina de base e é a principal causa de recorrência da cetoacidose.

Para levar. Saída da cetoacidose: insulina basal subcutânea 2 a 4 horas antes de desligar a infusão venosa. Desligar primeiro é a causa mais comum de rebote.

ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS Consensus Report: Hyperglycemic Crises in Adults with Diabetes (Diabetes Care 2024); Diretriz SBD 2024.

22

Neurologia · Dor em queimação nos pés com reflexos e vibração preservados e eletroneuromiografia normal: neuropatia de fibras finas, confirmada por biópsia de pele

Dado omitido **Gabarito D**

Mulher de 44 anos refere há 14 meses queimação e sensação de alfinetadas nos pés, que pioram à noite e ao contato com o lençol e agora atingem as pontas dos dedos das mãos. Nega fraqueza e desequilíbrio. Sem diabetes conhecido, não bebe e não usa medicamentos neurotóxicos. Exame: força normal, reflexos patelares e aquileus presentes e simétricos, vibração e propriocepção normais nos háluces, Romberg negativo; sensibilidade dolorosa e térmica reduzidas em botas e luvas curtas. Glicemia de jejum 94 mg/dL, HbA1c 5,5%, vitamina B12, TSH, eletroforese de proteínas e sorologias para HIV e hepatite C normais. Eletroneuromiografia dos quatro membros normal. A reumatologista cogita fibromialgia. Para confirmar a neuropatia, o exame mais adequado é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *sensibilidade dolorosa e térmica reduzidas em botas e luvas curtas*

Resolução. Faltam os achados que costumam selar uma polineuropatia: aquileus abolidos, perda vibratória e eletroneuromiografia alterada. Daí o rótulo de fibromialgia ou a ideia de repetir a eletroneuromiografia. Mas a eletroneuromiografia avalia só fibras grossas mielinizadas, e a vibração e os reflexos também dependem delas. Dor em queimação distal com alodinia e perda de sensibilidade dolorosa e térmica em bota e luva é lesão de fibras finas (A-delta e C), que a eletroneuromiografia não enxerga. O exame que confirma é a biópsia de pele com contagem da densidade de fibras nervosas intraepidérmicas, minimamente invasiva e validada pela EFNS/PNS; depois se busca a causa (teste oral de tolerância à glicose, doenças autoimunes, amiloidose, Fabry).

A) RM de coluna cervical e lombar

Errada. Seria o exame numa radiculopatia ou mielopatia, com dor em dermátomo, sinais piramidais ou nível sensitivo; o padrão aqui é distal e simétrico.

B) Nova eletroneuromiografia em 6 meses ARMADILHA

Errada, é a armadilha. A neuropatia de fibras finas pura mantém a eletroneuromiografia normal; repeti-la só adia o diagnóstico.

C) Biópsia de nervo sural

Errada. Reservada a suspeita de vasculite ou amiloidose com neuropatia de fibras grossas; é mais invasiva e pouco sensível para fibras finas.

D) Biópsia de pele (fibras intraepidérmicas) CORRETA

Correta. Dor neuropática distal com perda térmica e dolorosa e eletroneuromiografia normal: biópsia de pele com densidade de fibras intraepidérmicas.

Para levar. Eletroneuromiografia normal não afasta neuropatia: dor em queimação com perda térmica e dolorosa e reflexos preservados é fibra fina, e quem confirma é a biópsia de pele.

EFNS/PNS guideline on the use of skin biopsy in the diagnosis of small fiber neuropathy (Lauria et al., Eur J Neurol 2010); AAN/AANEM/AAPM&R practice parameter, evaluation of distal symmetric polyneuropathy (England et al., Neurology 2009).

---

23 Imunologia e alergia · Sífilis na gestante com anafilaxia prévia à penicilina: dessensibilização e penicilina benzatina, porque só a penicilina trata o feto

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Gestante de 24 anos, com 20 semanas, tem VDRL 1:32 e teste treponêmico reagente no pré-natal, sem lesões cutâneas ou mucosas e sem sintomas neurológicos ou oculares; não sabe quando se infectou. Relata que aos 18 anos, minutos após injeção de penicilina benzatina para amigdalite, teve urticária generalizada, edema de lábios, sibilância e hipotensão, tratados com adrenalina na emergência. Nega outras alergias. Sorologia para HIV não reagente. PA 110 × 70 mmHg. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Gestante de 24 anos, com 20 semanas

Resolução. A história de anafilaxia à penicilina é verdadeira e grave, e o reflexo é trocar o antibiótico, com a ceftriaxona como alternativa de manual na sífilis fora da gestação. Mas na gestante só a penicilina benzatina atravessa a placenta e trata o feto de forma comprovada; qualquer outro esquema conta como tratamento inadequado e o recém-nascido é tratado como sífilis congênita. Por isso a gestante com alergia à penicilina mediada por IgE é dessensibilizada, em ambiente hospitalar, e recebe o esquema completo de benzatina (aqui, sífilis latente de duração ignorada: três doses semanais). Com reação remota leve e não grave, o teste de provocação direta seria possível; com anafilaxia, dessensibilização. Doxiciclina é contraindicada na gestação, e a azitromicina falha por resistência.

A) Ceftriaxona 1 g/dia por 10 dias ARMADILHA

Errada. Seria uma alternativa fora da gestação; na gestante não é considerada tratamento adequado para prevenir sífilis congênita.

B) Azitromicina 2 g em dose única

Errada. Há resistência de Treponema pallidum aos macrolídeos e não trata o feto.

C) Dessensibilização e penicilina benzatina CORRETA

Correta. Anafilaxia prévia em gestante: dessensibilizar e tratar com penicilina benzatina.

D) Doxiciclina por 28 dias

Errada. Seria a alternativa para a não gestante alérgica; tetraciclinas são contraindicadas na gestação.

Para levar. Sífilis na gestação só se trata com penicilina: alergia mediada por IgE pede dessensibilização, e não troca de antibiótico.

PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST, Ministério da Saúde (2022); CDC STI Treatment Guidelines (2021); Drug allergy: a 2022 practice parameter update (AAAAI/ACAAI).

---

24 Cardiologia · Prótese mecânica mitral no primeiro trimestre com varfarina acima de 5 mg: trocar por heparina de baixo peso ajustada pelo anti-Xa

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 29 anos, com prótese mecânica de duplo folheto em posição mitral há 6 anos, por sequela reumática, usa varfarina 7,5 mg por dia, com INR estável entre 2,5 e 3,5 nos últimos meses. Está em ritmo sinusal, assintomática, com prótese normofuncionante no ecocardiograma recente. Descobre gestação de 6 semanas, planejada, e deseja mantê-la. Não há sangramento. A conduta anticoagulante mais adequada até o fim do primeiro trimestre é:

O DADO QUE DECIDE

usa varfarina 7,5 mg por dia

Resolução. Manter a varfarina é a isca porque ela é, de fato, o anticoagulante mais eficaz contra trombose de prótese mecânica na gestação, e a diretriz permite mantê-la no primeiro trimestre quando a dose diária necessária é de até 5 mg, faixa em que o risco de embriopatia é baixo. O limiar decide: com 7,5 mg por dia, o risco de embriopatia varfarínica (hipoplasia nasal, epífises pontilhadas) e de perda fetal sobe, e a recomendação é substituir entre a 6ª e a 12ª semana por heparina de baixo peso em dose terapêutica, duas vezes ao dia, ajustada pelo anti-Xa (pico e vale) semanalmente, ou por heparina não fracionada intravenosa com TTPa. No segundo trimestre volta-se à varfarina até cerca de 36 semanas, quando se troca de novo pela heparina para o parto. Os anticoagulantes orais diretos são contraindicados em prótese mecânica, e heparina profilática é insuficiente.

A) Trocar por dabigatrana

Errada. A dabigatrana é contraindicada em prótese mecânica (excesso de trombose e sangramento no estudo RE-ALIGN) e atravessa a placenta.

B) Trocar por AAS e heparina profilática

Errada. Heparina em dose profilática, mesmo com AAS, não protege prótese mecânica mitral e associa-se a trombose de prótese.

C) Trocar por heparina de baixo peso ajustada pelo anti-Xa CORRETA

Correta. Com varfarina acima de 5 mg por dia, a troca entre 6 e 12 semanas por heparina de baixo peso terapêutica, ajustada pelo anti-Xa, reduz a embriopatia sem desproteger a prótese.

D) Manter a varfarina na dose atual ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Manter a varfarina no primeiro trimestre é aceitável quando a dose é de até 5 mg por dia; com 7,5 mg, o risco de embriopatia e perda fetal justifica a troca.

Para levar. Prótese mecânica na gestação: varfarina de até 5 mg/dia pode ser mantida no primeiro trimestre; acima de 5 mg, troque entre 6 e 12 semanas por heparina de baixo peso terapêutica com anti-Xa. DOAC nunca.

ESC 2018 Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy; Posicionamento SBC sobre cardiopatia e gravidez 2020; ACC/AHA 2020 Guideline for valvular heart disease

---

25

Gastroenterologia · Câncer gástrico difuso na mãe antes dos 50 e câncer lobular de mama na tia: teste germinativo para CDH1, apesar de endoscopia normal

Rótulo verdadeiro | Gabarito A

Mulher de 32 anos procura avaliação porque a mãe morreu aos 44 anos de câncer gástrico do tipo difuso, com células em anel de sinete, e a tia materna teve carcinoma lobular de mama aos 47 anos. Assintomática. Fez endoscopia há 1 mês com biópsias aleatórias do estômago (6 fragmentos), todas normais, e pesquisa de Helicobacter pylori negativa. A irmã teve H. pylori erradicado no ano passado. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

carcinoma lobular de mama aos 47 anos

Resolução. A endoscopia com biópsias normais e o H. pylori negativo são verdadeiros e tranquilizam, e a vigilância endoscópica parece a continuação natural. Mas a combinação de câncer gástrico difuso antes dos 50 anos e carcinoma lobular de mama antes dos 70 na mesma família preenche os critérios para pesquisar mutação germinativa do CDH1 (síndrome do câncer gástrico difuso hereditário). Nessa síndrome os focos de células em anel de sinete crescem sob mucosa normal, e a endoscopia, mesmo com protocolo extenso de biópsias, perde a maioria deles. O teste genético vem primeiro porque define a conduta: se positivo, discute-se gastrectomia total profilática (em geral entre 20 e 30 anos) e rastreio de mama por ressonância; se negativo, a gastrectomia não se justifica. H. pylori não explica câncer difuso familiar.

A) Teste genético germinativo para CDH1 CORRETA

Correta. Câncer gástrico difuso antes dos 50 e câncer lobular de mama na família: critério para teste germinativo do CDH1.

B) Endoscopia anual com biópsias aleatórias ARMADILHA

Errada. É a armadilha: a endoscopia não afasta câncer gástrico difuso hereditário, cujos focos ficam sob mucosa normal; vigilância sem o teste não define nada.

C) Gastrectomia total profilática

Errada. Gastrectomia profilática só se indica com mutação confirmada; fazê-la antes do teste é fazer mais do que o caso pede.

D) Pesquisa de H. pylori nos familiares
Errada. H. pylori está ligado ao câncer gástrico intestinal esporádico, não à agregação de câncer difuso com lobular de mama.

Para levar. Câncer gástrico difuso precoce ou associado a carcinoma lobular de mama na família: teste germinativo do CDH1; endoscopia normal não tranquiliza.

International Gastric Cancer Linkage Consortium: Hereditary diffuse gastric cancer: updated clinical practice guidelines. Lancet Oncol (2020); NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment (2025)

---

26 Hematologia · LMA com t(8;21) em remissão com doença residual negativa: risco favorável e consolidação com citarabina em altas doses, sem transplante

Grade X / Y **Gabarito A**

Homem de 38 anos, com leucemia mieloide aguda: leucócitos 12.000/mm³, blastos mieloides com bastonetes de Auer, cariótipo 46,XY,t(8;21)(q22;q22.1) com fusão RUNX1::RUNX1T1, mutação de KIT no éxon 17, FLT3 e TP53 sem mutação. Após indução com daunorrubicina e citarabina, está em remissão completa, com doença residual mensurável negativa por PCR do transcrito de fusão. Tem um irmão HLA-idêntico disponível e deseja o tratamento com maior chance de cura e menor toxicidade. A categoria de risco pela ELN 2022 e a terapia pós-remissão são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

mutação de KIT no éxon 17

Resolução. A mutação de KIT na LMA com t(8;21) foi, por anos, considerada marcador de pior prognóstico, e quem guarda essa regra classifica como risco adverso e manda para transplante, sobretudo com irmão compatível disponível. A ELN 2022 classifica as LMA com fatores de ligação ao core (t(8;21) e inv(16)) como risco favorável independentemente de KIT, e o que hoje separa os pacientes de pior evolução é a doença residual mensurável. Com remissão completa e DRM negativa, o risco é favorável e a consolidação é citarabina em altas doses (3 a 4 ciclos), com seguimento seriado do transcrito RUNX1::RUNX1T1. O transplante alogênico em primeira remissão no risco favorável traz mortalidade sem recaída que supera o ganho; fica para DRM persistente ou em ascensão, ou para recaída.

A) Favorável / citarabina em altas doses CORRETA
Correta. t(8;21) é risco favorável pela ELN 2022, e com DRM negativa a consolidação é citarabina em altas doses.

B) Favorável / transplante alogênico com o irmão
Errada. A categoria está certa, mas transplante em primeira remissão no risco favorável com DRM negativa expõe a toxicidade sem benefício.

C) Adverso / transplante alogênico com o irmão ARMADILHA
Errada nas duas metades, é a armadilha. Classificar pela mutação de KIT é regra antiga; a ELN 2022 a retirou.

D) Adverso / citarabina em altas doses
Errada. A consolidação está certa, mas a categoria não; e no risco adverso o caminho seria transplante.

Para levar. LMA com t(8;21) ou inv(16) é risco favorável pela ELN 2022, com ou sem KIT; com DRM negativa, consolidar com citarabina em altas doses e acompanhar o transcrito, sem transplante em primeira remissão.

Döhner H et al., Diagnosis and management of AML in adults: 2022 ELN recommendations (Blood 2022); NCCN Guidelines Acute Myeloid Leukemia (2025).

27

Infectologia · Nódulo pulmonar cavitado, lesão cerebral e abscesso subcutâneo no transplantado com bacilos ramificados fracamente álcool-ácido resistentes: Nocardia

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 58 anos, transplantado renal há 1 ano, usa tacrolimo, micofenolato e prednisona 10 mg/dia; suspendeu a profilaxia com sulfametoxazol-trimetoprima no 6º mês. Há 4 semanas tem febre, tosse com escarro purulento e perda de peso. Há 1 semana surgiu um nódulo flutuante e indolor no antebraço e, há 2 dias, cefaleia e parestesia na mão esquerda. TC de tórax: nódulo cavitado de 3 cm no lobo superior direito. RM de crânio: lesão com realce anelar no lobo parietal direito. Escarro: bacilos gram-positivos ramificados e filamentosos, fracamente álcool-ácido resistentes pela coloração de Kinyoun modificada; teste rápido molecular para M. tuberculosis negativo. Galactomanana sérica negativa. O agente mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

fracamente álcool-ácido resistentes pela coloração de Kinyoun modificada

Resolução. Bacilos álcool-ácido resistentes, nódulo cavitado no lobo superior e lesão cerebral num imunossuprimido levam direto à tuberculose, e a álcool-ácido resistência é um rótulo verdadeiro. O que separa é a morfologia e a intensidade: as micobactérias são bastonetes retos, fortemente álcool-ácido resistentes no Ziehl-Neelsen, enquanto Nocardia é um bacilo gram-positivo ramificado e filamentoso, fracamente álcool-ácido resistente, que aparece na coloração de Kinyoun modificada. A tríade pulmão, SNC e pele ou subcutâneo no transplantado que suspendeu o sulfametoxazol-trimetoprima é a apresentação da nocardiose disseminada, e o teste molecular negativo reforça. Actinomyces também é ramificado, mas não é álcool-ácido resistente e raramente dá doença disseminada no imunossuprimido. O tratamento é sulfametoxazol-trimetoprima em dose alta associado a imipenem (e amicacina ou ceftriaxona conforme o caso), por no mínimo 12 meses com acometimento do SNC.

A) Nocardia spp. CORRETA
Correta. Bacilo gram-positivo ramificado e fracamente álcool-ácido resistente, com pulmão, cérebro e subcutâneo num transplantado sem profilaxia.

B) Actinomyces israelii
Errada. Actinomyces é ramificado, mas não é álcool-ácido resistente e causa doença cervicofacial ou torácica por contiguidade, raramente disseminada.

C) Mycobacterium tuberculosis ARMADILHA
Errada. É a armadilha: micobactérias são bastonetes retos fortemente álcool-ácido resistentes, e o teste molecular foi negativo.

D) Aspergillus fumigatus
Errada. Aspergillus forma hifas septadas, não bacilos, e a galactomanana foi negativa.

Para levar. Bacilo gram-positivo ramificado e fracamente álcool-ácido resistente, com pulmão, SNC e pele no imunossuprimido, é Nocardia: sulfametoxazol-trimetoprima em dose alta e investigação do SNC.

Margalit I et al. How do I manage nocardiosis? Clin Microbiol Infect 2021; AST Infectious Diseases Community of Practice, Nocardia infections in solid organ transplantation (2019).

28

Nefrologia · Hipertensão com hipocalemia, renina e aldosterona suprimidas na indução da leucemia mieloide aguda · excesso aparente de mineralocorticoide pelo posaconazol

Droga a deduzir **Gabarito B**

Homem de 58 anos, com leucemia mieloide aguda em quimioterapia de indução, recebe há cinco semanas a profilaxia antifúngica oral recomendada para a neutropenia prolongada da indução, com um triazólico de amplo espectro que cobre fungos filamentosos. Era normotenso. Agora com PA de 164/100 mmHg em medidas repetidas, edema discreto e fraqueza. Exames: potássio 2,6 mEq/L, bicarbonato 33 mEq/L, magnésio 2,0 mg/dL, cloro urinário 64 mEq/L, potássio urinário 48 mEq/L, renina suprimida, aldosterona de 2 ng/dL (4 a 31), cortisol matinal 14 µg/dL, ACTH normal. Não usa corticoide, diurético, alcaçuz ou fludrocortisona. TC de adrenais normal. O mecanismo mais provável do distúrbio é:

O DADO QUE DECIDE

aldosterona de 2 ng/dL (4 a 31)

Resolução. Hipertensão nova com hipocalemia, alcalose e perda renal de potássio é o retrato do hiperaldosteronismo primário, mas a aldosterona está suprimida: o excesso é de outro mineralocorticoide. Com renina e aldosterona baixas, as opções são Liddle, excesso aparente de mineralocorticoide (alcaçuz, carbenoxolona ou drogas) ou outro esteroide. A droga não é nomeada, mas o triazólico de profilaxia na indução da LMA é o posaconazol, que inibe a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2 (e, em parte dos casos, também a 11-beta-hidroxilase, acumulando 11-desoxicorticosterona), num efeito que depende do nível sérico: o cortisol deixa de ser inativado no túbulo distal e ocupa o receptor mineralocorticoide. Uma mutação do ENaC não surgiria aos 58 anos em quem era normotenso, e ACTH e cortisol normais afastam secreção ectópica. A conduta é trocar o antifúngico ou reduzir a exposição, com espironolactona se preciso.

A) Mutação ativadora do ENaC
Errada. Liddle tem o mesmo perfil de renina e aldosterona baixas, mas é hereditário e começa na juventude; aqui a hipertensão é nova, com droga nova.

B) Inibição da 11-beta-HSD2 renal CORRETA
Correta. O posaconazol inibe a 11-beta-HSD2 e o cortisol passa a agir como mineralocorticoide, com renina e aldosterona suprimidas.

C) Secreção ectópica de ACTH
Errada. Secreção ectópica de ACTH daria cortisol e ACTH muito elevados, ambos normais aqui.

D) Hiperaldosteronismo primário ARMADILHA
Errada. É a isca do fenótipo; hiperaldosteronismo primário exige aldosterona alta, e ela está em 2 ng/dL.

Para levar. Hipertensão hipocalêmica com renina e aldosterona baixas: pense em droga que inibe a 11-beta-HSD2 (alcaçuz, posaconazol) antes de pensar em doença genética.

Thompson GR 3rd et al. In vivo 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase inhibition in posaconazole-induced hypertension and hypokalemia, Antimicrob Agents Chemother 2017; Nguyen MH et al. Posaconazole serum drug levels associated with pseudohyperaldosteronism, Clin Infect Dis 2020; Endocrine Society Primary Aldosteronism guideline (2016).

---

29 Pneumologia · Hidrotórax hepático com febre e líquido ascítico sem peritonite: toracocentese diagnóstica para empiema bacteriano espontâneo

Negativo no meio **Gabarito D**

Homem de 54 anos com cirrose alcoólica Child-Pugh C, abstinente há 1 ano, em uso de espironolactona, furosemida e propranolol, tem derrame pleural direito há 6 meses, puncionado duas vezes para alívio, sempre com transudato. Há 2 dias tem febre de 38,4 °C, piora da dispneia e sonolência. PA 102/64 mmHg, FC 104 bpm, SpO2 93% em ar ambiente; asterixe presente; ascite moderada; sem dor abdominal. Radiografia de tórax: derrame à direita até a metade do hemitórax, semelhante ao de 3 semanas atrás, sem opacidade no pulmão contralateral. Paracentese diagnóstica: 120 polimorfonucleares/mm³, proteína total 0,9 g/dL, cultura em andamento. Urina tipo 1 normal; hemoculturas colhidas. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

120 polimorfonucleares/mm³

Resolução. O líquido ascítico com 120 polimorfonucleares afasta a peritonite bacteriana espontânea, a urina é normal, e o derrame é o mesmo de sempre na radiografia: o apressado conclui que o foco está escondido no pulmão e pede a TC de tórax. O dado que manda é o próprio derrame: num cirrótico com hidrotórax hepático, febre ou piora clínica sem foco definido pedem toracocentese diagnóstica, porque o empiema bacteriano espontâneo (infecção do hidrotórax sem pneumonia) ocorre em até 13% dos cirróticos com hidrotórax e, em cerca de 40% dos casos, sem peritonite associada. O diagnóstico é feito com cultura positiva e mais de 250 neutrófilos/mm³, ou cultura negativa e mais de 500, sem pneumonia que o explique; o líquido deve ser semeado em frascos de hemocultura à beira do leito. A TC não substitui a análise do líquido e atrasa o diagnóstico. Na nova paracentese não há o que ganhar, porque a ascite já foi analisada e não há suspeita de peritonite secundária.

A) Ecocardiograma transtorácico
Errada. Seria pedido para afastar causa cardíaca de derrame ou hipertensão portopulmonar; não investiga a febre.

B) Nova paracentese em 48 horas
Errada. Repetir a paracentese em 48 horas avalia resposta ao tratamento da peritonite ou suspeita de peritonite secundária; aqui a ascite não está infectada.

C) TC de tórax com contraste ARMADILHA
Errada. Procuraria pneumonia oculta ou loculação, mas não analisa o líquido; o foco mais provável é o próprio hidrotórax, e só a punção o diagnostica.

D) Toracocentese diagnóstica com cultura CORRETA
Correta. Hidrotórax hepático com febre sem foco e ascite sem peritonite: toracocentese com contagem celular e cultura em frasco de hemocultura para empiema bacteriano espontâneo.

Para levar. Cirrótico com hidrotórax e febre sem foco: puncionar o tórax. Empiema bacteriano espontâneo pode ocorrer sem peritonite bacteriana espontânea (cultura positiva com mais de 250 neutrófilos, ou mais de 500 com cultura negativa).

AASLD Practice Guidance: Diagnosis, Evaluation and Management of Ascites, Spontaneous Bacterial Peritonitis and Hepatorenal Syndrome (Biggins SW et al., Hepatology 2021); EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis (2018).

---

30 Endocrinologia · Contraindicação formal dos agonistas do receptor de GLP-1: neoplasia endócrina múltipla tipo 2, e não pancreatite prévia

Qualificador **Gabarito C**

Entre as condições abaixo, a que constitui contraindicação formal, prevista na bula norte-americana (FDA), ao uso de agonistas do receptor de GLP-1, como a semaglutida e a liraglutida, é:

O DADO QUE DECIDE

contraindicação formal, prevista na bula norte-americana (FDA)

Resolução. Pancreatite é o efeito adverso mais lembrado da classe, e por isso atrai; mas na bula ela aparece como precaução: a droga deve ser suspensa se houver pancreatite durante o uso, e a história prévia pede cautela, não proibição. A contraindicação formal é história pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide e neoplasia endócrina múltipla tipo 2, porque os agonistas de GLP-1 causaram hiperplasia de células C e carcinoma medular em roedores. A retinopatia proliferativa pede vigilância com semaglutida, pela piora inicial descrita no SUSTAIN-6 quando a glicemia cai rápido, mas não impede o uso. Na DRC estágio 4, liraglutida, dulaglutida e semaglutida dispensam ajuste e reduzem desfechos renais no FLOW.

A) Retinopatia diabética proliferativa
Errada. Retinopatia proliferativa pede acompanhamento oftalmológico ao iniciar semaglutida, sem contraindicá-la.

B) Pancreatite aguda prévia ARMADILHA
Errada. É a armadilha: pancreatite é precaução (suspender se ocorrer), não contraindicação formal.

C) Neoplasia endócrina múltipla tipo 2 CORRETA
Correta. História pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide ou NEM 2 é a contraindicação formal da classe.

D) Doença renal crônica estágio 4
Errada. Na DRC avançada os agonistas de GLP-1 não exigem ajuste e têm benefício renal comprovado.

Para levar. Agonistas de GLP-1: contraindicação formal é carcinoma medular de tireoide ou NEM 2 (pessoal ou familiar). Pancreatite, retinopatia e gastroparesia são precauções.

Bulas norte-americanas (FDA) de semaglutida e liraglutida; ADA Standards of Care in Diabetes 2026, seção 9; Perkovic e cols., FLOW (NEJM 2024).

---

31 Neurologia · Síndrome de Korsakoff: a memória imediata (repetição de dígitos) é a função preservada

Qualificador **Gabarito A**

Na síndrome amnéstica de Korsakoff que se segue à encefalopatia de Wernicke, a função de memória que se mantém relativamente preservada é:

O DADO QUE DECIDE

relativamente preservada

Resolução. A armadilha é achar que a síndrome de Korsakoff é só amnésia anterógrada e que o passado fica intacto: a amnésia retrógrada existe, com gradiente temporal (os anos mais próximos do início da doença se perdem mais que a infância), e por isso a memória de fatos anteriores não é a resposta. O déficit central é anterógrado: o paciente não aprende informação nova e não guarda o que aconteceu nos últimos dias, e preenche as lacunas com confabulação. O que se mantém é a memória imediata (o span de atenção, como repetir uma sequência de dígitos logo após ouvi-la), além da memória de procedimentos e de boa parte da inteligência geral. A lesão está nos corpos mamilares e no tálamo dorsomedial, e a tiamina previne mais do que reverte.

A) Repetição imediata de dígitos CORRETA
Correta. O span imediato (repetir dígitos) depende da atenção, não do circuito de consolidação, e fica preservado.

B) Aprendizado de informação nova
Errada. O aprendizado de informação nova é o núcleo do déficit anterógrado.

C) Memória de fatos antigos ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Há amnésia retrógrada com gradiente temporal; a memória remota é só parcialmente poupada.

D) Memória dos últimos dias
Errada. Fatos dos últimos dias dependem da consolidação, que é o que falha.

Para levar. Korsakoff: amnésia anterógrada grave, retrógrada com gradiente temporal e confabulação; memória imediata e de procedimentos preservadas.

Kopelman MD et al. The Korsakoff syndrome: clinical aspects, psychology and treatment. Alcohol Alcohol 2009; EFNS guidelines for Wernicke encephalopathy 2010.

---

32 Reumatologia · Periartrite aguda bilateral de tornozelos com febre e hiperuricemia em homem: síndrome de Löfgren sem eritema nodoso, e não gota

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 33 anos procura atendimento por dor e edema nos dois tornozelos há 12 dias, que o impedem de caminhar, com febre de 38 °C. Nega uretrite, diarreia, lesões de pele, tosse e dispneia. Tem obesidade e bebe cerveja nos fins de semana. Exame físico: edema, calor e eritema periarticulares difusos nos dois tornozelos, sem nódulos cutâneos; demais articulações normais. Ultrassonografia: edema de partes moles e tenossinovite, sem derrame tibiotársico significativo. Exames: ácido úrico 8,4 mg/dL, VHS 70 mm/h, PCR 48 mg/L, fator

reumatoide e FAN não reagentes, cálcio normal. Radiografia de tórax: linfonodomegalia hilar bilateral. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

Radiografia de tórax: linfonodomegalia hilar bilateral

Resolução. Homem obeso, que bebe cerveja, com ácido úrico de 8,4 e tornozelos inflamados: o rótulo de gota é verdadeiro e forte. Mas gota começa monoarticular, não acomete os dois tornozelos de forma simétrica e periarticular em adulto jovem na primeira crise, e não explica adenopatia hilar bilateral. A combinação de periartrite aguda bilateral de tornozelos, febre e adenopatia hilar bilateral é síndrome de Löfgren, e no homem o eritema nodoso costuma faltar, sendo a periartrite de tornozelos a manifestação dominante. Com a tríade, o diagnóstico é clínico e de bom prognóstico, com regressão espontânea na maioria; trata-se com anti-inflamatório. Poncet exigiria tuberculose ativa.

A) Artrite reativa
Errada. Daria oligoartrite assimétrica após uretrite ou diarreia, sem adenopatia hilar.

B) Síndrome de Löfgren CORRETA
Correta. Periartrite bilateral de tornozelos, febre e adenopatia hilar bilateral; no homem, o eritema nodoso costuma faltar.

C) Gota poliarticular ARMADILHA
Errada. Hiperuricemia é rótulo verdadeiro, mas não explica adenopatia hilar nem periartrite simétrica bilateral.

D) Reumatismo de Poncet
Errada. Artrite reativa à tuberculose ativa, que não há no caso; a adenopatia simétrica fala contra.

Para levar. Periartrite aguda bilateral de tornozelos com febre e adenopatia hilar bilateral é síndrome de Löfgren, mesmo sem eritema nodoso (frequente no homem); hiperuricemia não faz o diagnóstico de gota.

ATS Clinical Practice Guideline: Diagnosis and Detection of Sarcoidosis (2020); Grunewald J, Eklund A. Sex-specific manifestations of Löfgren's syndrome (Am J Respir Crit Care Med, 2007).

33

Gastroenterologia · Constipação refratária a laxativos com contração paradoxal do esfíncter ao esforço: dissinergia evacuatória, e não trânsito lento

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 38 anos tem constipação há 4 anos, sem sangramento, anemia ou perda de peso. Colonoscopia aos 36 anos normal; TSH, cálcio e glicemia normais; sem medicações constipantes. Usou fibras, polietilenoglicol em dose plena e bisacodil por 3 meses, sem melhora. Evacua 2 vezes por semana, com esforço intenso, sensação de bloqueio anal e necessidade de pressionar o períneo para evacuar, mesmo com fezes amolecidas. Nega dor abdominal relacionada às evacuações. Toque retal: tônus de repouso normal, sem abaulamento da parede anterior do reto; ao pedir que faça força para evacuar, o esfíncter anal se contrai e o períneo não desce. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

o esfíncter anal se contrai e o períneo não desce

Resolução. Constipação que não responde a laxativos osmóticos e estimulantes recebe o rótulo de trânsito lento, e a falha dos laxativos é real. Mas a queixa aqui é de saída: esforço intenso mesmo com fezes moles, sensação de bloqueio, necessidade de pressionar o períneo e, no toque, contração paradoxal do esfíncter com o períneo que não desce ao fazer força. Isso é dissinergia evacuatória, distúrbio funcional da evacuação em que a musculatura do assoalho pélvico se contrai em vez de relaxar; ela própria lentifica o trânsito, por isso um estudo de trânsito feito antes engana. A confirmação é pela manometria anorretal com teste de expulsão do balão, e o tratamento é biofeedback, e não mais laxativo. A síndrome do intestino irritável exige dor abdominal ligada às evacuações, que ela nega, e a retocele daria abaulamento da parede anterior do reto ao esforço, ausente no toque.

A) Constipação de trânsito lento ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a falha dos laxativos é verdadeira, mas os sintomas são de saída e o toque mostra contração paradoxal; a dissinergia também lentifica o trânsito e confunde esse diagnóstico.

B) Síndrome do intestino irritável com constipação
Errada. Exige dor abdominal recorrente relacionada às evacuações; ela nega dor, e o problema está na saída.

C) Retocele sintomática
Errada. Daria abaulamento da parede anterior do reto ao esforço, às vezes com necessidade de apoio vaginal; o toque não mostra abaulamento e sim contração paradoxal do esfíncter.

D) Dissinergia evacuatória CORRETA
Correta. Esforço, bloqueio, manobra perineal e contração paradoxal do esfíncter com períneo que não desce: dissinergia, a confirmar por manometria com expulsão do balão e tratar com biofeedback.

Para levar. Constipação refratária com esforço, bloqueio e manobras manuais, e contração paradoxal do esfíncter no toque: dissinergia evacuatória; confirma-se com manometria anorretal e expulsão do balão e trata-se com biofeedback, não com mais laxativo.

AGA Technical Review on Constipation (2013); ACG Clinical Guidelines: Management of Benign Anorectal Disorders (2021)

---

34 Cardiologia · Crise hipertensiva minutos após antiemético antidopaminérgico em mulher rotulada de pânico: feocromocitoma, e não síndrome serotoninérgica

Droga a deduzir | Gabarito D

Mulher de 39 anos, em tratamento de 'transtorno de pânico' com sertralina 50 mg há 8 meses, procura o pronto-socorro por vômitos após almoço em restaurante. Recebe no braço o antiemético antidopaminérgico de uso mais comum na emergência. Cerca de 15 minutos depois, apresenta cefaleia occipital intensa, palpitações, sudorese profusa e palidez, com sensação de morte iminente. PA 236×134 mmHg, FC 138 bpm, temperatura axilar de 36,8 °C. Pupilas isocóricas de 4 mm; sem clônus, com reflexos normais e sem rigidez; pele fria e pálida. ECG: taquicardia sinusal. Glicemia 228 mg/dL, sem diabetes conhecido. A irmã conta que as 'crises de pânico' começaram há 1 ano, duram 20 a 30 minutos e vêm com dor de cabeça e suor, e que a PA dela 'às vezes está alta e às vezes normal'. A causa mais provável da crise atual é:

O DADO QUE DECIDE

sem clônus, com reflexos normais e sem rigidez; pele fria e pálida

Resolução. O antiemético antidopaminérgico mais usado no pronto-socorro é a metoclopramida, e com sertralina em uso a síndrome serotoninérgica parece óbvia: é a isca. Mas a serotoninérgica se reconhece pelo exame neuromuscular (clônus induzível ou espontâneo, hiper-reflexia, tremor), com hipertermia, midríase, diarreia e pele quente e ruborizada, pelos critérios de Hunter; aqui não há clônus, os reflexos são normais, a temperatura é normal e a pele está fria e pálida, que é vasoconstrição adrenérgica. A metoclopramida bloqueia receptores D2 que inibem a liberação de catecolaminas no tumor cromafim e é gatilho clássico de paroxismo de feocromocitoma, assim como contraste, glicocorticoide, anestesia e betabloqueador isolado. A tríade cefaleia, sudorese e palpitações em crises de 20 a 30 minutos, a PA lábil e a hiperglicemia completam o quadro, e o rótulo de pânico atrasou o diagnóstico em um ano. O tratamento da crise é alfabloqueio intravenoso (fentolamina) ou nitroprussiato, nunca betabloqueador antes do alfa.

A) Síndrome neuroléptica maligna
Errada. A síndrome neuroléptica maligna evolui em dias, com rigidez em cano de chumbo, hipertermia e CK elevada; aqui foram 15 minutos, sem rigidez e sem febre.

B) Síndrome serotoninérgica ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a resposta com clônus, hiper-reflexia, hipertermia e pele quente após a metoclopramida em quem usa ISRS; nenhum desses achados está presente.

C) Crise tireotóxica
Errada. A crise tireotóxica tem febre alta, pele quente e úmida e um fator precipitante como infecção ou cirurgia; não é desencadeada em minutos por antidopaminérgico e não causa palidez.

D) Crise de feocromocitoma CORRETA
Correta. Paroxismo adrenérgico desencadeado por metoclopramida, com palidez, hiperglicemia, PA lábil e crises prévias de cefaleia, sudorese e palpitações, é feocromocitoma.

Para levar. Paroxismo hipertensivo minutos após metoclopramida, contraste, glicocorticoide ou betabloqueador é feocromocitoma até prova em contrário; sem clônus e com pele pálida, não é síndrome serotoninérgica.

Endocrine Society Clinical Practice Guideline: Pheochromocytoma and Paraganglioma (Lenders JWM et al., 2014); Lenders JWM et al., Lancet 2005 (drogas que precipitam crise); Hunter Serotonin Toxicity Criteria (Dunkley EJC et al., QJM 2003)

---

35 Hematologia · Neutropenia isolada meses após R-CHOP com PET em remissão: neutropenia tardia pelo rituximabe

Droga a deduzir | Gabarito C

Mulher de 58 anos, com linfoma difuso de grandes células B, terminou 6 ciclos de R-CHOP há 4 meses, com PET-CT de fim de tratamento em remissão metabólica completa (Deauville 2). Assintomática e afebril. Hemograma de rotina: Hb 12,4 g/dL, leucócitos 1.900/mm³, neutrófilos 420/mm³, linfócitos 1.200/mm³, plaquetas 210.000/mm³. Os hemogramas de 2 e 3 meses após o último ciclo eram normais. Sem linfonodomegalias nem esplenomegalia, LDH normal, B12 e folato normais. Esfregaço sem blastos e sem displasia. A causa mais provável da neutropenia é:

O DADO QUE DECIDE

Os hemogramas de 2 e 3 meses após o último ciclo eram normais

Resolução. Citopenia nova depois de quimioterapia com ciclofosfamida e doxorrubicina faz temer neoplasia mieloide relacionada à terapia ou recidiva com infiltração da medula. Mas a neoplasia relacionada a alquilante surge, em geral, 5 a 7 anos depois (e 1 a 3 anos para inibidores de topoisomerase), com displasia e outras citopenias; a recidiva viria com LDH alta, linfonodos ou outras linhagens comprometidas, e o PET foi negativo. A droga a deduzir está no R do esquema: o rituximabe causa neutropenia isolada de início tardio (late-onset neutropenia), semanas a meses após a última dose, depois de hemogramas normais, em até 5% a 25% dos tratados. Costuma ser autolimitada e se resolve em semanas, mesmo com contagens abaixo de 500; sem febre, a conduta é observação com hemogramas seriados e orientação para procurar atendimento se houver febre, com fator estimulador de colônias reservado para infecção ou neutropenia febril.

A) Hiperesplenismo
Errada. Não há esplenomegalia, e o hiperesplenismo afetaria também as plaquetas.

B) Recidiva com infiltração medular
Errada. PET em remissão, LDH normal e plaquetas e Hb normais contrariam infiltração medular.

C) Neutropenia tardia pelo rituximabe CORRETA
Correta. Neutropenia isolada meses após rituximabe, com hemogramas intermediários normais e remissão do linfoma.

D) Neoplasia mieloide relacionada à terapia ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Aparece anos após alquilante, com displasia e outras citopenias; 4 meses é cedo demais.

Para levar. Neutropenia isolada semanas a meses depois de rituximabe, com hemogramas intermediários normais, é neutropenia tardia pelo anticorpo: em geral autolimitada.

Wolach O et al., Late-onset neutropenia after rituximab treatment (Medicine 2010); NCCN Guidelines B-cell Lymphomas (2025), seção de toxicidades.

36

Infectologia · Lesão cerebral que não responde ao tratamento para toxoplasma na aids, em quem tem sorologia para Chagas reagente: reativação da doença de Chagas

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 44 anos, nascido na zona rural do norte de Minas Gerais, tem aids e abandonou a TARV há 2 anos (CD4 atual de 22 células/mm³). Há 3 semanas tem cefaleia, febre e hemiparesia esquerda, com uma crise focal. RM: lesão única de 4 cm na substância branca frontoparietal direita, com realce heterogêneo, edema e efeito de massa, poupando os núcleos da base. IgG anti-Toxoplasma reagente; recebeu sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico por 12 dias, com piora clínica e aumento da lesão. Sorologia para Trypanosoma cruzi reagente por dois métodos. ECG: bloqueio de ramo direito com hemibloqueio anterior esquerdo. Líquor: 38 células/mm³, linfomonocitárias, proteína 96 mg/dL, glicose normal, criptococo negativo. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

Sorologia para Trypanosoma cruzi reagente por dois métodos

Resolução. Lesão expansiva na aids que não responde ao tratamento empírico para toxoplasma leva ao linfoma primário do SNC e à biópsia, e esse é um raciocínio verdadeiro. Mas este paciente tem um antecedente que muda a lista: nasceu em área endêmica, tem sorologia para T. cruzi reagente e um ECG com bloqueio de ramo direito e hemibloqueio anterior esquerdo, a assinatura da cardiopatia chagásica. Com CD4 abaixo de 100, a doença de Chagas pode reativar como meningoencefalite com lesão expansiva (chagoma cerebral), que predomina na substância branca dos hemisférios, é frequentemente grande e única, e não responde a sulfadiazina e pirimetamina. O diagnóstico se confirma pela pesquisa de tripomastigotas no líquor ou no sangue, ou pela biópsia, e o tratamento é benznidazol com TARV. Criptococoma é raro e o antígeno foi negativo.

A) Neurotoxoplasmose refratária
Errada. Piora e aumento da lesão após 12 dias de esquema adequado, com lesão fora dos núcleos da base, afastam toxoplasmose responsiva.

B) Reativação da doença de Chagas CORRETA
Correta. Sorologia para T. cruzi reagente, ECG de cardiopatia chagásica, CD4 de 22 e lesão de substância branca sem resposta ao tratamento para toxoplasma.

C) Criptococoma cerebral
Errada. O criptococoma é raro, e a pesquisa de criptococo no líquor foi negativa.

D) Linfoma primário do SNC ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a hipótese sem antecedente epidemiológico, com lesão periventricular ou subependimária; aqui a sorologia e o ECG apontam Chagas.

Para levar. Na aids avançada com lesão cerebral que não responde ao tratamento para toxoplasma, em quem tem sorologia para Chagas reagente, pensar em reativação (chagoma cerebral) antes de concluir linfoma.

Ministério da Saúde, PCDT HIV adultos, módulo 2 (2023); PCDT Doença de Chagas (MS/CONITEC, 2018); II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas (2015).

37

Nefrologia · Efluente turvo na diálise peritoneal com mais de 100 leucócitos e predomínio neutrofílico · antibiótico intraperitoneal empírico, sem esperar a cultura

Limiar **Gabarito A**

Homem de 54 anos, em diálise peritoneal automatizada há dois anos, procura o serviço porque o efluente da drenagem da manhã está turvo, com dor abdominal difusa leve. Tax 37,6 °C, PA 134/82 mmHg, FC 90 bpm, abdome com dor discreta à descompressão, orifício de saída do cateter sem secreção nem hiperemia, túnel sem dor. Efluente colhido após permanência de 2 horas: 640 leucócitos/mm³ com 82% de neutrófilos; Gram sem bactérias; cultura em frasco de hemocultura em andamento. Não usa antibiótico há seis meses e não tem alergias. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

640 leucócitos/mm³ com 82% de neutrófilos

Resolução. Peritonite com febre leva ao antibiótico intravenoso e à internação, que é o reflexo de quem trata a peritonite do cirrótico. Na diálise peritoneal, efluente turvo com mais de 100 leucócitos/mm³ e mais de 50% de neutrófilos, após permanência de pelo menos 2 horas, já fecha o diagnóstico, e o Gram negativo não muda

a conduta. A ISPD recomenda iniciar logo, sem esperar a cultura, cobertura empírica para Gram-positivos (vancomicina ou cefalosporina de primeira geração) e Gram-negativos (ceftazidima, cefepima ou aminoglicosídeo), pela via intraperitoneal, que dá concentração muito maior no peritônio que a venosa. Sem sepse grave, o tratamento pode ser ambulatorial, e a retirada do cateter fica para peritonite refratária, recidivante ou fúngica.

A) Vancomicina e ceftazidima intraperitoneais CORRETA
Correta. Critério de peritonite atingido: cobertura empírica de Gram-positivos e Gram-negativos pela via intraperitoneal.

B) Ceftriaxona intravenosa e internação ARMADILHA
Errada. É a isca da peritonite bacteriana espontânea; na diálise peritoneal a via preferida é a intraperitoneal, e o quadro não é grave.

C) Retirada imediata do cateter de Tenckhoff
Errada. Retirar o cateter é para peritonite refratária após 5 dias, recidivante, fúngica ou com infecção de túnel associada.

D) Aguardar a cultura para tratar
Errada. O limiar diagnóstico já foi atingido; atrasar o antibiótico aumenta a falha e a perda da membrana.

Para levar. Na diálise peritoneal, efluente com mais de 100 leucócitos e mais de 50% de neutrófilos é peritonite: antibiótico intraperitoneal empírico para Gram-positivos e negativos, já.

Li PK et al. ISPD peritonitis guideline recommendations: 2022 update on prevention and treatment. Perit Dial Int 2022.

---

38 Pneumologia · Silicose e infecção latente por tuberculose: o ponto de corte da prova tuberculínica

Limiar **Gabarito A**

Segundo o Ministério da Saúde, no adulto com silicose, sem tuberculose ativa e sem outra indicação, a enduração da prova tuberculínica a partir da qual se trata a infecção latente é:

O DADO QUE DECIDE
silicose

Resolução. A silicose aumenta muito o risco de adoecer por tuberculose, e por isso o aluno a coloca junto com os grupos de 5 mm (pessoas vivendo com HIV, contatos, usuários de anti-TNF, transplantados, sequela fibrótica de tuberculose não tratada). No quadro do Ministério da Saúde, porém, a silicose está no grupo de 10 mm ou IGRA positivo, ao lado de diabetes, diálise, neoplasias em quimioterapia, baixo peso e tabagismo pesado. Antes de tratar, exclui-se doença ativa com radiografia (e escarro se houver sintomas), o que na silicose exige atenção porque as lesões se confundem. Nenhum grupo trata com qualquer enduração, e 15 mm não é ponto de corte usado no Brasil.

A) 10 mm CORRETA
Correta. Silicose está no grupo de prova tuberculínica de 10 mm ou mais (ou IGRA positivo).

B) 5 mm ARMADILHA
Errada. É o corte de HIV, contatos, anti-TNF, transplante e sequela fibrótica não tratada.

C) 15 mm
Errada. Ponto de corte usado em outros países para pessoas sem risco; não faz parte do quadro brasileiro.

D) Qualquer enduração
Errada. Nenhuma indicação brasileira dispensa o corte; mesmo os de maior risco usam 5 mm.

Para levar. ILTB no Brasil: 5 mm para HIV, contatos, anti-TNF, transplante e sequela fibrótica; 10 mm para silicose, diabetes, diálise, neoplasia em quimioterapia, baixo peso e tabagismo pesado.

Ministério da Saúde, Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2ª ed. atualizada (2019); Nota Informativa nº 4/2024 CGTM/DATHI/SVSA/MS (indicações de tratamento da ILTB); Protocolo de Vigilância da Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis no Brasil, 2ª ed. (2022).

39

Imunologia e alergia · Angioedema hereditário tipo 1 antes de extração dentária e na crise laríngea: concentrado de inibidor de C1 antes e icatibanto na crise, e não adrenalina

Grade X / Y

Gabarito D

Mulher de 26 anos tem angioedema hereditário tipo 1 (C4 baixo, inibidor de C1 baixo em nível e função), com crises de edema de face e de dor abdominal sem urticária. Não usa profilaxia de longo prazo. Vai extrair os terceiros molares sob anestesia local na próxima semana. Ela pergunta o que fazer antes do procedimento e, se tiver edema de laringe depois, o que deve receber na emergência. A profilaxia antes da extração e o tratamento da crise laríngea são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

sem urticária

Resolução. Angioedema de laringe leva ao reflexo de anafilaxia: adrenalina, anti-histamínico e corticoide. Mas o angioedema hereditário é mediado por bradicinina, não por histamina, e por isso não responde a nenhum dos três. Procedimentos dentários são gatilho importante e a laringe fica próxima: antes deles se faz profilaxia de curto prazo, de preferência com concentrado de inibidor de C1 1 a 6 horas antes (plasma fresco é alternativa só quando o concentrado não está disponível). Na crise, sobretudo laríngea, trata-se com concentrado de inibidor de C1 ou icatibanto (antagonista do receptor B2 da bradicinina), com preparo para via aérea avançada.

A) Anti-histamínico e corticoide / adrenalina intramuscular ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na anafilaxia ou no angioedema histaminérgico; no hereditário, bradicinérgico, não funciona.

B) Plasma fresco antes / adrenalina intramuscular
Errada. Plasma é alternativa de profilaxia só sem concentrado disponível, e a adrenalina não trata a crise.

C) Nenhuma profilaxia / anti-histamínico venoso
Errada. Extração dentária pede profilaxia de curto prazo, e anti-histamínico não age na bradicinina.

D) Concentrado de inibidor de C1 / icatibanto CORRETA

Correta. Concentrado de inibidor de C1 antes do procedimento; icatibanto (ou concentrado) na crise laríngea.

Para levar. Angioedema hereditário é bradicinérgico: adrenalina, anti-histamínico e corticoide não funcionam; profilaxia de curto prazo com concentrado de inibidor de C1 antes de procedimento e icatibanto ou concentrado na crise.

WAO/EAACI Guideline for the Management of Hereditary Angioedema (2021 revision and update); Diretrizes brasileiras do angioedema hereditário, ASBAI (2022).

40

Endocrinologia · Hipocalcemia com PTH alto e fósforo alto, baixa estatura e braquidactilia, rotulada como hipovitaminose D: pseudo-hipoparatireoidismo tipo 1A

Rótulo verdadeiro

Gabarito A

Mulher de 22 anos é avaliada por parestesias periorais e cãibras desde a adolescência e por uma crise convulsiva há 1 ano, atribuída a epilepsia, para a qual usa carbamazepina. Nega cirurgia cervical. Exame: altura 1,49 m, face arredondada, IMC 30 kg/m², encurtamento do quarto e do quinto metacarpianos bilateralmente, sinal de Chvostek positivo. Exames: cálcio total 6,9 mg/dL (albumina 4,2 g/dL), fósforo 6,4 mg/dL, magnésio 2,0 mg/dL, creatinina 0,7 mg/dL, PTH 312 pg/mL (referência 15 a 65), 25-hidroxivitamina D 18 ng/mL, fosfatase alcalina normal, TSH 6,8 mUI/L. Tomografia de crânio com calcificações nos núcleos da base. A UBS registrou hiperparatireoidismo secundário à deficiência de vitamina D induzida pela carbamazepina. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

fósforo 6,4 mg/dL

Resolução. Hipocalcemia com PTH alto, vitamina D de 18 ng/mL e carbamazepina (indutora que acelera o catabolismo da vitamina D) montam um rótulo verdadeiro de hiperparatireoidismo secundário, e é a armadilha. O dado que derruba está no fósforo: na deficiência de vitamina D, o PTH alto age no rim e o fósforo cai; aqui ele está alto, com função renal normal, o que significa que o rim não responde ao PTH, isto é, resistência ao PTH. Hipocalcemia, hiperfosfatemia e PTH alto com creatinina normal definem o pseudo-hipoparatireoidismo. A baixa estatura, a face arredondada, a obesidade e a braquidactilia do quarto e quinto metacarpianos são a osteodistrofia hereditária de Albright, e o TSH alto sugere resistência a outros hormônios ligados à proteína Gs, o que caracteriza o tipo 1A. A crise convulsiva e as calcificações dos núcleos da base são da hipocalcemia crônica, não de epilepsia primária.

A) Pseudo-hipoparatireoidismo tipo 1A CORRETA

Correta. Hipocalcemia com fósforo alto e PTH alto, função renal normal, fenótipo de Albright e resistência ao TSH: tipo 1A.

B) Hiperparatireoidismo secundário à hipovitaminose D ARMADILHA

Errada. É a armadilha: no secundário à falta de vitamina D o fósforo fica baixo, e não alto, porque o rim responde ao PTH.

C) Hipoparatireoidismo autoimune

Errada. No hipoparatireoidismo o fósforo também é alto, mas o PTH é baixo ou inapropriadamente normal, e não de 312.

D) Pseudopseudo-hipoparatireoidismo
Errada. Tem o fenótipo de Albright, mas sem resistência hormonal: cálcio, fósforo e PTH são normais.

Para levar. Hipocalcemia: o PTH separa hipopara (baixo) de resistência ou causa secundária (alto), e o fósforo separa pseudo-hipopara (fósforo alto) da falta de vitamina D (fósforo baixo).

Mantovani e cols., First international Consensus Statement on pseudohypoparathyroidism and related disorders (Nat Rev Endocrinol 2018).

---

41 Gastroenterologia · Hematoquezia volumosa com instabilidade e endoscopia alta normal: angiotomografia antes da colonoscopia

Negativo no meio | Gabarito A

Homem de 76 anos, com fibrilação atrial em uso de apixabana e coronariopata em uso de AAS, apresenta quatro episódios de hematoquezia volumosa em 3 horas. Chega com PA 84×50 mmHg e FC 122 bpm; após cristaloide, mantém PA 90×56 mmHg com transfusão em curso. Hb 7,1 g/dL. Endoscopia digestiva alta de urgência feita há 1 hora: sem sangue no estômago e no duodeno e sem lesões. Última apixabana há 6 horas. Além de suspender os antitrombóticos e considerar a reversão do anticoagulante, o exame mais adequado agora é:

O DADO QUE DECIDE

mantém PA 90×56 mmHg com transfusão em curso

Resolução. Hematoquezia com endoscopia alta normal é sangramento baixo, e a colonoscopia após preparo é o exame padrão da hemorragia digestiva baixa, por isso atrai. Mas isso vale para o paciente estável. Com instabilidade persistente apesar de volume e transfusão, e sangramento ativo, a diretriz recomenda angiotomografia primeiro: ela localiza o sangramento ativo em minutos, sem preparo, e guia a arteriografia com embolização. A endoscopia alta normal, sem sangue no duodeno, foi o passo certo para afastar fonte alta (que responde por parte das hematoquezias com instabilidade). A cintilografia é lenta e localiza mal, e a retossigmoidoscopia não alcança o cólon direito, sede frequente de diverticulose e angiodisplasia que sangram muito.

A) Angiotomografia de abdome e pelve CORRETA
Correta. Hemorragia digestiva baixa com instabilidade persistente: angiotomografia para localizar e guiar a embolização.

B) Colonoscopia após preparo rápido ARMADILHA
Errada. É a armadilha: é o exame do paciente estável; no instável com sangramento ativo, a angiotomografia vem antes.

C) Cintilografia com hemácias marcadas
Errada. É lenta, exige sangramento contínuo e localiza mal; não serve ao paciente instável.

D) Retossigmoidoscopia flexível
Errada. Não avalia o cólon direito e não resolve a localização.

Para levar. Hemorragia digestiva baixa: estável, colonoscopia após preparo; instável ou com sangramento ativo, angiotomografia primeiro, depois arteriografia com embolização.

ACG Clinical Guideline: Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding (2023); ESGE Guideline: Diagnosis and management of acute lower GI bleeding (2021)

---

42 Neurologia · Túnel do carpo bilateral leve no terceiro trimestre, sem déficit motor: órtese noturna inicialmente, sem infiltração nem cirurgia

Omissão **Gabarito B**

Gestante de 32 anos, com 33 semanas, queixa-se há 5 semanas de formigamento noturno nos três primeiros dedos das duas mãos, que a acorda e melhora ao sacudir as mãos. Ganhou 11 kg na gestação e tem edema de mãos e pés; PA 112/70 mmHg, sem proteinúria. Exame: Phalen e Tinel positivos bilateralmente, sensibilidade da eminência tenar preservada, força de abdução curta do polegar grau 5, sem atrofia tenar. TSH e glicemia normais. ENMG: lentificação da condução sensitiva do mediano no punho, latência motora distal normal, sem desnervação. A conduta mais adequada, inicialmente, é:

O DADO QUE DECIDE

latência motora distal normal, sem desnervação

Resolução. Sintoma noturno que acorda a paciente e ENMG alterada levam a querer tratar com algo mais forte, e a infiltração parece o meio-termo seguro, por isso é a armadilha. O qualificador 'inicialmente' e a gravidade decidem: é túnel do carpo leve (só condução sensitiva alterada, latência motora normal, sem desnervação, sem atrofia nem fraqueza), causado pela retenção hídrica da gestação, que costuma regredir nas semanas após o parto. A primeira conduta é a órtese de punho em posição neutra à noite, que alivia a maioria. A infiltração fica para quem não melhora com a órtese, e a cirurgia para déficit motor, desnervação ou persistência depois do parto. A sensibilidade tenar preservada é o esperado, porque o ramo cutâneo palmar passa por fora do túnel, e não sugere outro diagnóstico.

A) Infiltração de corticoide no túnel do carpo ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria o segundo passo se a órtese falhasse; como conduta inicial num quadro leve e autolimitado, faz mais do que o caso pede.

B) Órtese de punho em posição neutra à noite CORRETA
Correta. Túnel do carpo leve da gestação: órtese noturna em posição neutra, com expectativa de melhora após o parto.

C) Liberação cirúrgica do túnel do carpo
Errada. Cirurgia é para déficit motor, atrofia ou desnervação, ou para persistência após o parto; nada disso aqui.

D) Prednisona oral por 10 dias
Errada. Corticoide oral tem efeito curto e não é conduta inicial, ainda mais na gestação.

Para levar. Túnel do carpo leve, sobretudo na gestação: órtese noturna primeiro; infiltração se falhar, cirurgia se houver déficit motor ou desnervação.

AAOS Clinical Practice Guideline: Management of Carpal Tunnel Syndrome 2016; Padua L et al. Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management. Lancet Neurol 2016.

---

43 Hematologia · Hipercalcemia grave no mieloma com clearance de 16 mL/min: denosumabe no lugar do bisfosfonato

Limiar **Gabarito D**

Homem de 70 anos, com mieloma múltiplo IgA lambda diagnosticado há 1 semana, ainda sem tratamento, é admitido por sonolência, constipação e poliúria. PA 108 × 66 mmHg, mucosas secas. Cálcio total corrigido 14,6 mg/dL, creatinina 3,9 mg/dL (clearance estimado de 16 mL/min), sem valor basal conhecido, potássio 4,2 mEq/L, albumina 3,4 g/dL. Iniciados soro fisiológico a 250 mL/h e calcitonina subcutânea; após 6 horas, diurese de 120 mL/h, sem sinais de congestão. Além da dexametasona e do tratamento do mieloma, o agente antirreabsortivo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

clearance estimado de 16 mL/min

Resolução. Na hipercalcemia da malignidade, a sequência de manual é hidratação, calcitonina como ponte e bisfosfonato intravenoso, de preferência ácido zoledrônico, o que faz marcá-lo sem olhar o rim. Mas o limiar decide: com clearance abaixo de 30 mL/min, o zoledronato não é recomendado (nefrotoxicidade, necrose tubular e glomeruloesclerose), e o pamidronato, se usado, exige dose reduzida e infusão lenta, nunca 90 mg em 2 horas. O denosumabe, anticorpo anti-RANKL, não é eliminado pelo rim, reduz o cálcio de forma eficaz e é a escolha do IMWG para o mieloma com insuficiência renal grave. Exige vigilância de hipocalcemia nos dias seguintes, mais provável na DRC, com dosagens seriadas e reposição de cálcio e vitamina D assim que a calcemia normalizar. A causa da lesão renal (hipercalcemia, desidratação, cadeia leve) deve ser abordada em paralelo.

A) Ácido zoledrônico 4 mg intravenoso ARMADILHA
Errada, é a armadilha. É a escolha com clearance acima de 30 mL/min; abaixo disso, é nefrotóxico e contraindicado.

B) Pamidronato 90 mg em 2 horas
Errada. Pamidronato na DRC grave só em dose menor e infusão de 4 a 6 horas; 90 mg em 2 horas lesa o rim.

C) Ibandronato oral diário
Errada. Bisfosfonato oral tem absorção mínima e efeito lento; não trata hipercalcemia grave.

D) Denosumabe 120 mg subcutâneo CORRETA
Correta. Hipercalcemia grave no mieloma com clearance de 16 mL/min: denosumabe, que não depende do rim.

Para levar. Hipercalcemia da malignidade com clearance abaixo de 30 mL/min: denosumabe em vez de zoledronato, com vigilância de hipocalcemia nos dias seguintes.

Terpos E et al., IMWG recommendations for the treatment of myeloma-related bone disease (Lancet Oncol 2021); Endocrine Society Clinical Practice Guideline, Treatment of hypercalcemia of malignancy in adults (2023).

---

44 Infectologia · Corynebacterium em um de dois pares de hemocultura, sem dispositivo e com febre já resolvida: contaminação, sem antibiótico

Omissão **Gabarito D**

Mulher de 70 anos está internada há 4 dias por AVC isquêmico, com acesso venoso periférico trocado a cada 72 horas, sem cateter central, sem prótese valvar ou articular e sem marca-passo. No 3º dia teve um pico febril de 37,9 °C após broncoaspiração presenciada, e foram colhidos dois pares de hemocultura de punções diferentes. Hoje está afebril há 24 horas, PA 132 × 80 mmHg, FC 78 bpm, leucócitos 9.800/mm³, PCR em queda. O laboratório informa crescimento de Corynebacterium sp. em apenas 1 de 2 pares, com positividade após 52 horas; o outro par está negativo no 5º dia. O sopro cardíaco está ausente. A conduta mais adequada em relação a esse resultado é:

O DADO QUE DECIDE

em apenas 1 de 2 pares

Resolução. Qualquer hemocultura positiva gera o reflexo de tratar, e a opção de repetir culturas e cobrir com vancomicina parece um meio-termo prudente. Mas Corynebacterium (difteroide), Cutibacterium, Bacillus não anthracis, Micrococcus e estafilococo coagulase-negativo são contaminantes de pele frequentes, e o critério para considerá-los patógenos é o crescimento em dois ou mais pares de punções diferentes, ou em um par em paciente com dispositivo intravascular ou prótese e quadro compatível. Aqui o crescimento foi em apenas um de dois pares, tardio, numa paciente sem cateter central, sem prótese, sem sopro, com febre explicada por broncoaspiração e já resolvida. Tratar contaminante custa toxicidade, resistência e dias de internação. Ecocardiograma e nova série de culturas não se justificam sem bacteremia verdadeira.

A) Vancomicina por 14 dias
Errada. Seria o tratamento de bacteremia verdadeira por corinebactéria em portador de dispositivo, com crescimento em mais de um par.

B) Repetir hemoculturas e iniciar vancomicina ARMADILHA
Errada. É a armadilha: soa prudente, mas trata contaminante e dispara investigação sem bacteremia verdadeira.

C) Ecocardiograma transesofágico
Errada. Investiga endocardite, que não tem base com um único par positivo para comensal de pele, sem dispositivo e sem sopro.

D) Considerar contaminação, sem antibiótico CORRETA
Correta. Comensal de pele em 1 de 2 pares, sem dispositivo, com febre explicada e resolvida, é contaminação.

Para levar. Comensal de pele (difteroide, Cutibacterium, coagulase-negativo) em um único par, sem dispositivo, é contaminação: não tratar.

Doern GV et al. A comprehensive update on the problem of blood culture contamination. Clin Microbiol Rev 2019; CDC/NHSN, critérios de infecção primária de corrente sanguínea (2024); ANVISA, Critérios Diagnósticos de IRAS (2017).

45 Cardiologia · Dupla lesão mitral reumática com B1 hipofonética, B3 e ictus desviado: insuficiência predominante, e a valvoplastia por balão está contraindicada

Grade X / Y **Gabarito B**

Mulher de 41 anos, com febre reumática aos 10 anos, refere dispneia aos pequenos esforços e ortopneia há 5 meses. Traz laudo de ecocardiograma de 6 anos atrás: 'dupla lesão mitral reumática'. PA 112×70 mmHg, FC 84 bpm, ritmo regular. Ictus no 6º espaço intercostal, na linha axilar anterior, amplo e propulsivo. B1 hipofonética, terceira bulha presente, sem estalido de abertura. Sopro holossistólico 3+/6 no foco mitral, irradiado para a axila, e ruflar mesodiastólico curto no ápice, sem reforço pré-sistólico. ECG: ritmo sinusal, sobrecarga de átrio e de ventrículo esquerdos. Radiografia: cardiomegalia à custa de VE. A lesão predominante e a intervenção mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

B1 hipofonética, terceira bulha presente, sem estalido de abertura

Resolução. Febre reumática com ruflar diastólico puxa a estenose mitral e a valvoplastia por balão, que é a isca. Mas na dupla lesão o exame físico diz qual lesão manda. Na estenose predominante, B1 é hiperfonética, há estalido de abertura, o VE é pequeno (ictus no lugar) e a terceira bulha é impossível, porque o enchimento rápido está bloqueado. Aqui é o oposto: B1 hipofonética (folhetos que não coaptam), B3 (grande volume regurgitado entrando no VE no início da diástole), ictus desviado, amplo e propulsivo e sobrecarga de VE, que são marcas de sobrecarga de volume da insuficiência. O ruflar curto sem estalido é de hiperfluxo pela valva, e não de estenose importante. Insuficiência mitral moderada ou maior é contraindicação à valvoplastia por balão, que a pioraria; a sintomática com insuficiência predominante vai para cirurgia (troca valvar ou plástica em centro experiente).

A) Estenose predominante / valvoplastia por cateter-balão ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a resposta com B1 hiperfonética, estalido de abertura e VE pequeno; aqui há B3, B1 hipofonética e ictus desviado, e a insuficiência importante contraindica o balão.

B) Insuficiência predominante / cirurgia valvar mitral CORRETA
Correta. B1 hipofonética, B3 e ictus desviado e propulsivo indicam insuficiência predominante, e a intervenção na sintomática é cirúrgica.

C) Estenose predominante / cirurgia valvar mitral
Errada na primeira metade. A cirurgia seria a conduta numa estenose com anatomia desfavorável ao balão, mas a semiologia mostra insuficiência predominante.

D) Insuficiência predominante / valvoplastia por cateter-balão
Errada na segunda metade. A insuficiência predominante está certa, mas é justamente ela que contraindica a valvoplastia por balão.

Para levar. Dupla lesão mitral: B1 hiperfonética, estalido e VE pequeno indicam estenose predominante; B1 hipofonética, B3 e ictus desviado indicam insuficiência predominante, que contraindica o balão.

Diretriz Brasileira de Valvopatias SBC 2020; ESC/EACTS 2021 Guidelines for valvular heart disease; ACC/AHA 2020 Guideline for valvular heart disease

46 Hepatologia · Gestante HBeAg reagente com carga viral muito alta e ALT normal: tenofovir para prevenir a transmissão vertical, mesmo sem indicação materna

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Gestante de 24 anos, com 24 semanas, tem HBsAg reagente no pré-natal. HBeAg reagente, anti-HBe não reagente, HBV-DNA de 8,4 × 10^7 UI/mL, ALT de 22 U/L em duas dosagens, ultrassonografia hepática normal. Anti-HIV e anti-HCV não reagentes. Assintomática. O hepatologista lembra que, na fase de imunotolerância, a hepatite B não se trata. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

HBV-DNA de 8,4 × 10^7 UI/mL

Resolução. A frase do hepatologista é um rótulo verdadeiro: com ALT normal e sem fibrose, a mãe não tem indicação de tratamento pela doença hepática. Mas a questão aqui é a criança. A vacina e a imunoglobulina ao nascer previnem a maioria das transmissões, porém falham em até 10% quando a carga viral materna é muito alta. Por isso, gestantes com HBV-DNA acima de 200.000 UI/mL (ou HBeAg reagente, quando a carga não está disponível) recebem tenofovir a partir de 24 a 28 semanas, mantido até o parto ou depois, conforme a avaliação materna, além da vacina e da imunoglobulina no recém-nascido nas primeiras 12 horas. Entecavir e interferon não são usados na gestação, e a via de parto segue indicação obstétrica.

A) Interferon peguilado durante a gestação
Errada. Interferon é contraindicado na gestação.

B) Tenofovir a partir de agora e imunoprofilaxia do recém-nascido CORRETA
Correta. Carga viral muito alta: tenofovir a partir de 24 a 28 semanas, mais vacina e imunoglobulina ao recém-nascido.

C) Entecavir até o parto e cesariana eletiva
Errada. Entecavir não tem segurança estabelecida na gestação, e a cesariana não reduz a transmissão da hepatite B.

D) Somente imunoprofilaxia do recém-nascido ARMADILHA
Errada. É a armadilha: com carga viral acima de 200.000 UI/mL a imunoprofilaxia isolada falha com frequência; é preciso reduzir a viremia materna.

Para levar. Hepatite B na gestação: HBV-DNA acima de 200.000 UI/mL (ou HBeAg reagente) indica tenofovir a partir de 24 a 28 semanas, mesmo sem indicação materna, somado à imunoprofilaxia do recém-nascido.

Ministério da Saúde: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais (2022) e PCDT Hepatite B e Coinfecções (2023); EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis B (2025)

47 Imunologia e alergia · Lesão violácea que volta no mesmo lugar a cada ciclo menstrual: erupção fixa pelo anti-inflamatório tomado nesses dias, e não pela droga de uso contínuo

Cronologia **Gabarito C**

Mulher de 27 anos procura atendimento pela quarta recorrência, em 8 meses, de uma mancha arredondada de 3 cm no lábio inferior, que arde, fica violácea, às vezes forma bolha e regride em 10 dias deixando mancha acastanhada, sempre no mesmo lugar. Usa losartana diariamente há 3 anos por hipertensão e, há 1 ano, toma naproxeno por 2 ou 3 dias a cada menstruação, por cólica. As lesões surgem algumas horas depois da primeira dose de cada ciclo. Nega febre, lesões em outras mucosas e vesículas agrupadas precedidas de formigamento. Exame físico: placa eritematoviolácea de 3 cm, bem delimitada, com halo acastanhado, no lábio inferior. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

algumas horas depois da primeira dose de cada ciclo

Resolução. Lesão que volta no mesmo lugar do lábio lembra herpes recorrente. Mas herpes vem com vesículas agrupadas e pródromo de formigamento, e não deixa hiperpigmentação residual, enquanto a placa violácea bem delimitada, às vezes bolhosa, que regride com mancha acastanhada e recorre sempre no mesmo sítio, é erupção fixa por droga. A cronologia identifica o agente: a lesão é intermitente e aparece horas após a primeira dose a cada ciclo, o que a liga ao naproxeno, tomado só nesses dias; a losartana, de uso contínuo há 3 anos, não explica crises intermitentes. AINEs, sulfonamidas, dipirona e tetraciclinas são as causas mais comuns. Basta suspender e trocar o analgésico, e o teste de contato na lesão residual pode confirmar.

A) Eritema multiforme recorrente
Errada. Eritema multiforme dá lesões em alvo múltiplas e acrais, em geral após herpes; não uma placa única recorrente no mesmo sítio.

B) Erupção fixa pela losartana
Errada. A losartana é contínua há 3 anos; não explica lesões intermitentes ligadas a cada ciclo.

C) Erupção fixa pelo naproxeno CORRETA
Correta. Placa no mesmo sítio, horas após a primeira dose, a cada uso intermitente: erupção fixa pelo naproxeno.

D) Herpes simples recorrente ARMADILHA
Errada. Herpes daria vesículas agrupadas com pródromo e sem pigmentação residual; esse quadro foi negado.

Para levar. Erupção fixa por droga recorre no mesmo sítio horas após cada exposição e deixa hiperpigmentação; o culpado é a droga de uso intermitente que coincide com as crises.

Anderson HJ, Lee JB. A review of fixed drug eruption with a special focus on generalized bullous fixed drug eruption (Medicina, 2021); Bolognia Dermatology, 4ª edição (2018).

48 Nefrologia · Potássio de 7,2 com ECG normal na leucemia linfocítica crônica com leucocitose extrema · pseudo-hipercalemia, confirmar em sangue total antes de tratar

Negativo no meio **Gabarito B**

Homem de 71 anos, com leucemia linfocítica crônica sem indicação de tratamento, em consulta de rotina, assintomático. Usa enalapril 10 mg/dia há oito anos, sem mudança recente de dose. Exames colhidos no laboratório do ambulatório, em tubo de soro, e enviados ao setor técnico por sistema pneumático: potássio 7,2 mEq/L, leucócitos 186.000/mm³ (92% linfócitos), hemoglobina 12,8 g/dL, plaquetas 140.000/mm³, creatinina 1,0 mg/dL, bicarbonato 25 mEq/L, glicemia 92 mg/dL. Exame físico normal, força muscular preservada. ECG: ritmo sinusal, 68 bpm, ondas T de amplitude normal, PR e QRS normais. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

ECG: ritmo sinusal, 68 bpm, ondas T de amplitude normal, PR e QRS normais

Resolução. Potássio de 7,2 é número de emergência e puxa o protocolo inteiro de hipercalemia. Mas nada no paciente acompanha o número: função renal normal, sem acidose, enalapril estável há anos, força preservada e, no meio do caso, um ECG inteiramente normal. Com 186.000 leucócitos frágeis, a coagulação no tubo de soro e o choque mecânico do sistema pneumático rompem células e liberam potássio depois da coleta, a pseudo-hipercalemia. O passo seguinte é medir o potássio em sangue total heparinizado num gasômetro, com transporte em mãos e sem centrifugação, antes de qualquer tratamento; tratar um potássio falso com insulina pode causar hipoglicemia e hipocalemia verdadeira.

A) Potássio urinário e gradiente transtubular
Errada. Investigar a excreção renal só faz sentido depois de confirmar que a hipercalemia é real.

B) Potássio em sangue total, levado em mãos CORRETA
Correta. Leucocitose extrema, tubo de soro e transporte pneumático com ECG normal: confirmar em sangue total antes de tratar.

C) Gluconato de cálcio e insulina com glicose ARMADILHA
Errada. É a isca do número; seria a conduta com hipercalemia confirmada ou com alteração no ECG, que aqui é normal.

D) Suspender o enalapril e iniciar quelante
Errada. O enalapril está estável há oito anos com creatinina normal; mudar a medicação por um valor provavelmente falso é tratar o laboratório.

Para levar. Hipercalemia sem causa e com ECG normal em quem tem leucocitose ou trombocitose extrema pede potássio em sangue total, transportado em mãos, antes de tratar.

Clase CM et al. Potassium homeostasis and management of dyskalemia: KDIGO Controversies Conference, Kidney Int 2020.

49

Pneumologia · Exacerbação aguda de fibrose pulmonar idiopática desencadeada por vírus: infecção identificada não exclui a exacerbação (definição de 2016)

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 71 anos com fibrose pulmonar idiopática há 3 anos (padrão de pneumonia intersticial usual na TC), em uso de nintedanibe, CVF de 62% e estável nos últimos 6 meses, teve coriza e dor de garganta há 14 dias, seguidas de piora progressiva da dispneia há 10 dias, sem febre. FR 30 irpm, SpO2 84% em ar ambiente, estertores em velcro bilaterais, sem edema nem turgência jugular. TC de tórax: vidro fosco bilateral e difuso, novo, sobreposto ao faveolamento basal, sem consolidação lobar. Angiotomografia sem embolia; BNP 90 pg/mL; ecocardiograma com FE de 60% e sem sinais de sobrecarga de volume. Painel molecular do swab nasofaríngeo: rinovírus detectado; procalcitonina 0,08 ng/mL; hemoculturas negativas. O diagnóstico mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

vidro fosco bilateral e difuso, novo, sobreposto ao faveolamento basal

Resolução. O rinovírus detectado é verdadeiro e puxa a leitura de que tudo se explica por uma virose, o que, pela definição antiga de 2007 (que exigia excluir infecção), afastaria a exacerbação aguda. A definição revisada do grupo internacional de 2016 mudou isso: exacerbação aguda de FPI é piora respiratória clinicamente significativa em menos de 1 mês, com vidro fosco ou consolidação bilateral nova sobre o padrão de pneumonia intersticial usual, não explicada por insuficiência cardíaca ou sobrecarga de volume. Ela pode ser idiopática ou desencadeada (infecção, procedimento, aspiração, droga), e a desencadeada tem o mesmo prognóstico ruim, com mortalidade hospitalar ao redor de 50%. Aqui a embolia foi afastada, e BNP e ecocardiograma afastam congestão. Progressão seria queda gradual da CVF em meses, não vidro fosco bilateral novo em dias. O nome importa porque muda o manejo e o prognóstico: suporte, manter o antifibrótico, corticoide como opção de recomendação fraca, e nada de ciclofosfamida, que aumentou a mortalidade no EXAFIP.

A) Infecção viral, sem exacerbação da FPI ARMADILHA
Errada. Seria a leitura com consolidação localizada e sem vidro fosco bilateral novo; pela definição de 2016, infecção identificada não exclui exacerbação, apenas a classifica como desencadeada.

B) Exacerbação aguda da FPI CORRETA
Correta. Menos de 1 mês, vidro fosco bilateral novo sobre o padrão usual, sem IC nem sobrecarga de volume: exacerbação aguda desencadeada por vírus.

C) Progressão da FPI
Errada. Progressão é queda gradual da CVF e da DLCO ao longo de meses, sem vidro fosco difuso novo em dias.

D) Congestão pulmonar
Errada. Seria o diagnóstico com BNP elevado, disfunção ventricular ou sobrecarga de volume; BNP de 90 pg/mL e ecocardiograma normal afastam.

Para levar. Exacerbação aguda de FPI (definição de 2016): menos de 1 mês, vidro fosco bilateral novo sobre o padrão usual, não explicado por IC ou volume. Infecção identificada não exclui: torna a exacerbação desencadeada, com o mesmo prognóstico.

Collard HR et al., Acute Exacerbation of Idiopathic Pulmonary Fibrosis: An International Working Group Report, Am J Respir Crit Care Med (2016); ATS/ERS/JRS/ALAT IPF Guideline (2011, atualização 2022); Naccache JM et al., EXAFIP, Lancet Respir Med (2022).

---

50 Endocrinologia · Testosterona baixa colhida à tarde no homem obeso com diabetes: repetir em jejum pela manhã antes de qualquer imagem ou reposição

Negativo no meio · Gabarito A

Homem de 54 anos, com diabetes tipo 2, obesidade (IMC 37 kg/m²) e apneia obstrutiva do sono em uso de CPAP, queixa-se de disfunção erétil e cansaço. Leu sobre reposição hormonal e trouxe exame feito por conta própria: testosterona total de 228 ng/dL (referência 264 a 916), colhida às 17 horas, após o almoço. Exame: pelos corporais preservados, testículos de 18 mL bilateralmente, sem ginecomastia. HbA1c 7,8%, TSH normal, prolactina 11 ng/mL, hemoglobina 15,4 g/dL, PSA 0,9 ng/mL. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

colhida às 17 horas, após o almoço

Resolução. Sintomas compatíveis e testosterona abaixo da referência parecem fechar hipogonadismo, e o apressado ou repõe ou já procura a causa central com ressonância, que é a armadilha do exame a mais. O dado no meio do caso invalida o número: a testosterona tem ritmo circadiano e cai após refeições com glicose, e a dosagem válida é a total, em jejum, entre 7 e 10 horas, confirmada em pelo menos duas ocasiões. Só depois de confirmar valores baixos se dosam LH e FSH; na obesidade, a SHBG baixa reduz a testosterona total sem reduzir a livre, e a livre (calculada ou por diálise) ajuda nos valores limítrofes. Ressonância de sela fica para hipogonadismo hipogonadotrófico com testosterona muito baixa (abaixo de 150), outros eixos alterados ou sintomas de massa. Iniciar testosterona sem confirmação trata um número que pode ser normal.

A) Repetir a testosterona total em jejum, pela manhã CORRETA
Correta. A testosterona colhida à tarde e após refeição não é válida: repetir total, em jejum, de manhã, em duas ocasiões.

B) Iniciar testosterona em gel
Errada. Reposição exige diagnóstico confirmado por duas dosagens matinais em jejum baixas e sintomas; aqui não foi confirmado.

C) Ressonância magnética de sela turca ARMADILHA
Errada. É a armadilha: ressonância é para hipogonadismo central confirmado com testosterona muito baixa ou outros eixos alterados.

D) Cariótipo e dosagem de FSH
Errada. Cariótipo investiga Klinefelter, com testículos pequenos e FSH alto; ele tem testículos de 18 mL e nem o hipogonadismo está confirmado.

Para levar. Hipogonadismo masculino só se diagnostica com testosterona total em jejum, pela manhã, baixa em duas dosagens; colhida à tarde ou após refeição não vale.

Endocrine Society 2018 (Testosterone Therapy in Men with Hypogonadism); AUA 2018 (Evaluation and Management of Testosterone Deficiency).